

COURS 1 - ACCOMPAGNEMENT NATUROPATHIQUE DES TROUBLES DU SYSTEME DIGESTIF

Léa SION Naturopathe & Musicothérapeute

Objectifs du cours

- Décrire et comprendre les pathologies digestives de la bouche jusqu'au pancréas
- Comprendre la complémentarité allopathie/naturopathie
- Apprendre à identifier les déséquilibres de terrain et à en rechercher la ou les causes

Sommaire

I. Introduction

II. Pathologies de la bouche

1. Inflammations buccales (gingivite, glossite)
2. Candidose buccale

III. Pathologies de l'estomac

1. Reflux gastro-œsophagien(RGO), gastrite chronique
2. Hernie hiatale

IV. Pathologies du foie et de la vésicule biliaire

1. Insuffisance hépatique, surcharge hépatique
2. NASH ou NAFLD
3. Lithiases biliaires

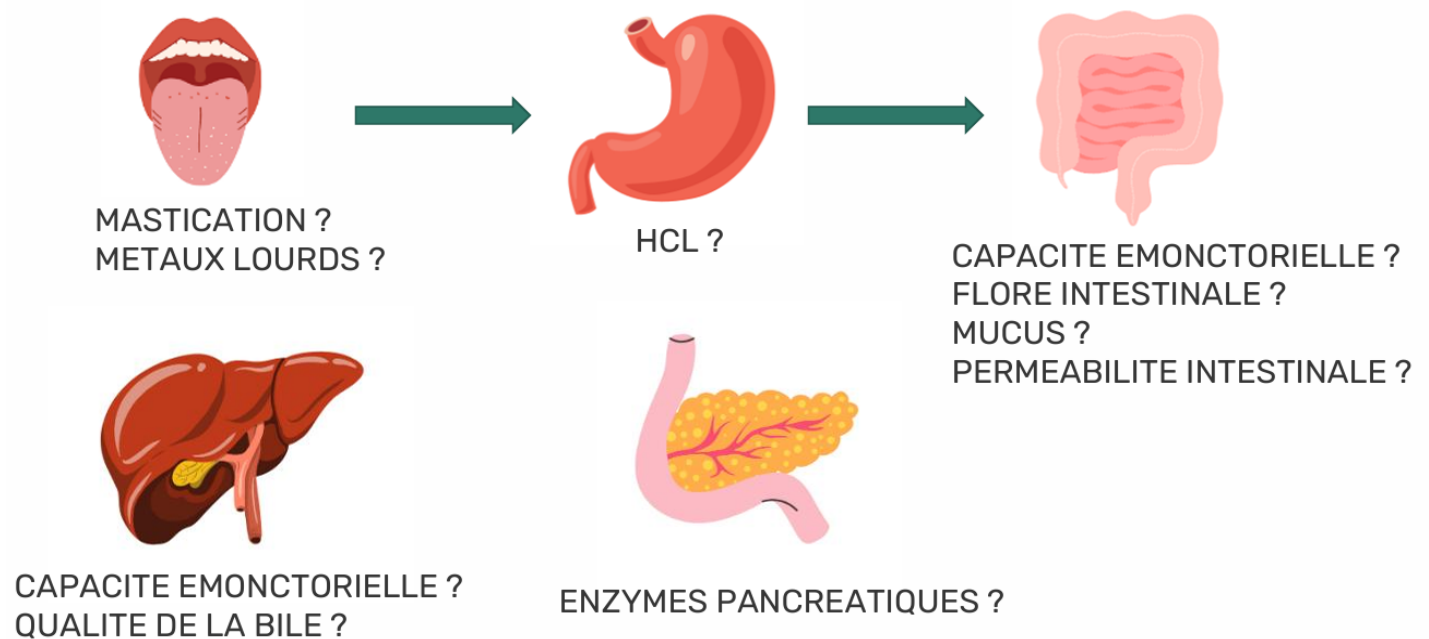
V. Pathologies du pancréas

1. Pancréatite

INTRODUCTION

Pour toutes les pathologies, nous verrons :

- La définition
- Les symptômes
- Le diagnostic
- Les causes possibles
- Les questions à poser en consultation
- Les bilans recommandés
- Les traitements allopathiques
- L'accompagnement naturopathique



Schema qui permet d'expliquer tout ce qui doit se passer dans votre tête quand vous accompagnez quelqu'un pour des troubles digestifs. Si quelqu'un vient vous voir pour des problématiques , par exemple intestinal ou au niveau du colon ,lui poser bien évidemment ces questions :

- ⇒ **Capacite emonctorielle**
- ⇒ **Est-ce que son intestin est capable d'éliminer suffisamment, autrement dit , est ce qu'il va a la selle tous les jours ?**
- ⇒ **Est-ce que sa flore intestinale est équilibrée ?**
- ⇒ **Est-ce qu'il a suffisamment de mucus ?**

En plus de toutes ces questions , il faut toujours regarder pour le système digestif ce qui se passe en amont Dites-vous bien que ce que vous mangez, ça commence par la bouche, ensuite l'estomac, intestin colon et en parallèle , le foie, le pancréas qui vont participer aussi a la digestion

➔ **Donc il faut toujours s'intéresser a ce qui se passe en amont et en aval :**

- ⇒ **Est-ce que la personne mastique bien ?**
- ⇒ **Est-ce que a l'étape de l'estomac , elle a assez d'HCL- ?**
- ⇒ **Pensez aux glandes annexes aussi qui font un gros travail de digestion**

PATHOLOGIES DE LA BOUCHE

Inflammations buccales (gingivite, glossite)

Rappels d'anatomie-physiologie

Activité enzymatique dans la bouche :

- **Au niveau de la langue** → Lipase linguale → Amorce la digestion des lipides
- **Au niveau des glandes salivaires** → Amylase salivaire → Amorce la digestion des glucides

Composition de la salive :

- **Salive** = Eau (97 à 99,5 %) + solutés
- **Solutés** = ions, enzymes, mucus, déchets, IgA, défensine et lysozyme

Rôles de la langue :

- Participe au goût
- Facilite la mastication
- Mélange les aliments avec la salive et les transforme en une masse compacte
- Participe à la déglutition et à la défense locale
- Permet aussi de prononcer les consonnes.

Flore buccale :

Flore commensale «amie» + **Flore pathogène avec bactéries** anaérobies, aérobies, champignon, virus notamment le candida albicans et l'HPV. => Si la flore pathogène prend le dessus alors s'installe un déséquilibre de la flore (buccale, vaginale..) et que les pathologies arrivent.

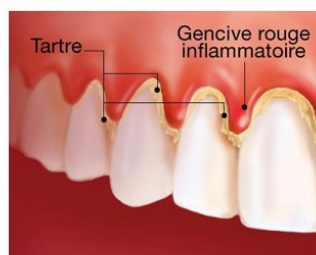
Pathologies de la bouche

GLOSSITE



<https://fr.wikipedia.org/wiki/Glossite>

GINGIVITE



<https://drvibert-dentiste-dechaussement-lyon.com/gingivites/>

CANDIDOSE BUCCALE



https://fr.wikipedia.org/wiki/Muguet_buccal

GLOSSITE Caractérisé par une langue décapitée, inflammée, fissurée

GINGIVITE Caractérisée par une accumulation de tartre qui va générer une inflammation de la gencive

CANDIDOSE BUCCALE : Se matérialise par une langue blanchâtre, dépôt blanchâtre lié à un excès souvent de champignon, donc candida

Définitions

	INFLAMMATION BUCCALE		MYCOSE BUCCALE
Dénomination	Glossite	Gingivite	Candidose
Définition / Symptômes	Inflammation de la langue. Langue rouge, décapillée par endroit, parfois fissurée qui peut provoquer des sensations de brûlure à l'ingestion de certains aliments. Porte aussi le nom de langue géographique .	Inflammation des gencives due à une accumulation de la plaque dentaire.	Infection de la langue. Provoquée par un champignon microscopique (Candida albicans le plus souvent) . Se manifeste par un dépôt blanchâtre sur la langue.
Evolution possible / Risques	Directement lié à la cause sous-jacente. Si lié à la maladie de Biermer, risque mortel .	Parodontite = inflammation des tissus de soutien de la dent provoquant une fonte de l'os dans laquelle la dent est implantée → Déchaussement.	Il peut y avoir glossite et candidose buccale en même temps.

Les consultants qui vont venir vous voir en séance ne vont pas forcément venir pour ces problématiques . Mais pour nous en tant que naturopathe, ces problématiques vont nous orienter pour caractériser le terrain

Ex : quand une personne arrive avec une glossite,(même si elle ne consulte pas pour cela) on peut s'imaginer, émettre une hypothèse qu'il est fort probable qu'elle est un terrain auto immun (la glossite est une maladie auto immune dans quasi tous les cas et porte le nom de langue géographique)

Le fait d'identifier un terrain auto immun va nous permettre d'agir en ce sens et poser des questions en lien avec l'auto-immunité sur d'autres systèmes.

La Glossite n'est pas une maladie grave mais peut la devenir si elle est liée à la maladie de Biermer et devenir mortelle

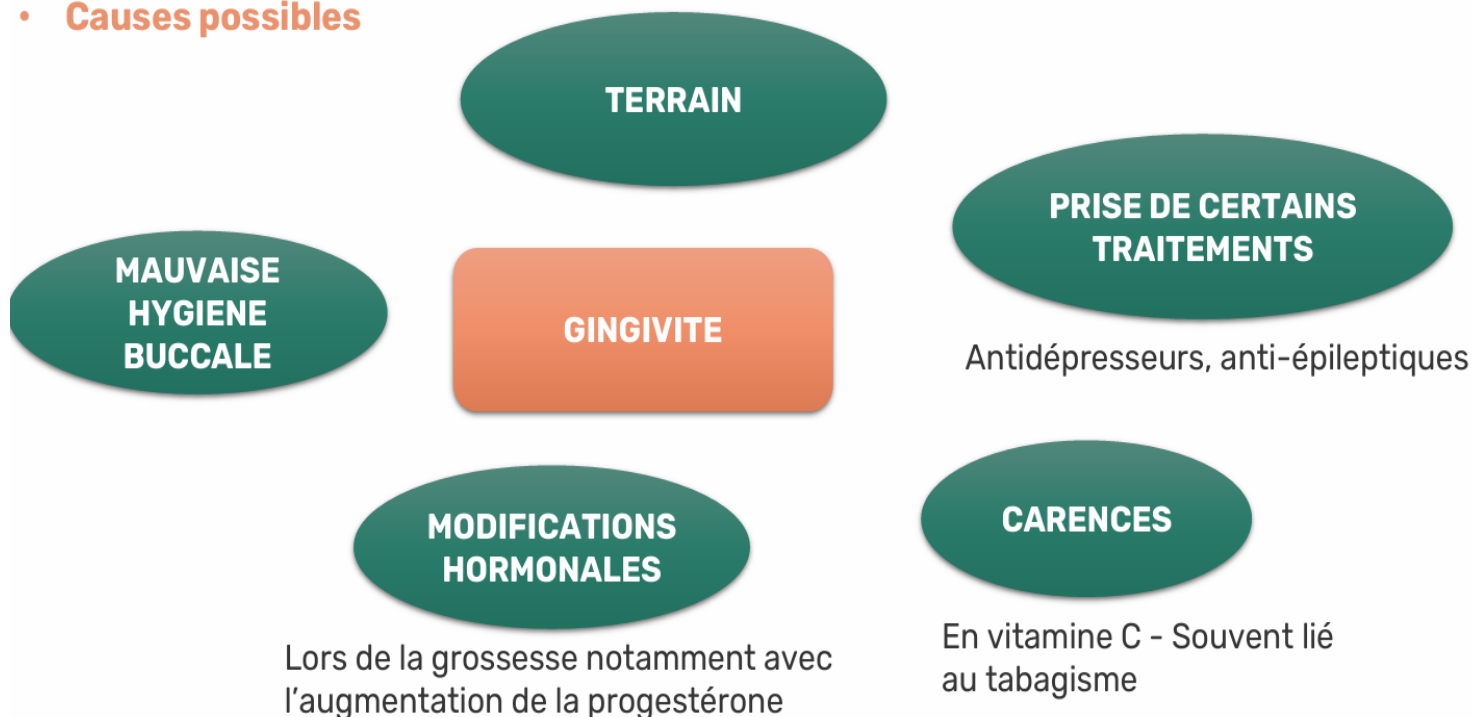
La maladie de Biermer est une maladie auto-immune, aussi appelée "anémie pernicieuse". Cette maladie associe une malabsorption au niveau gastrique, c'est-à-dire une inflammation chronique de la muqueuse gastrique entraînant une diminution du volume de la muqueuse de l'estomac ainsi qu'une anémie liée à une carence en vitamine B12.

La maladie de Biermer est donc la cause avérée de près de 50 % des carences en vitamine B12 de l'adulte. On parle d'anémie macrocytaire, car la maladie de Biermer se définit, notamment, par un faible taux d'hémoglobine ainsi que par la présence de globules rouges (hématies) dont la taille est anormalement volumineuse

Une des causes est une malabsorption intestinale de la vitamine B12 provoquée par un manque d'une protéine nommée facteur intrinsèque, protéine fabriquée par les cellules de la muqueuse de l'estomac

Gingivite

• Causes possibles



Si la cause est liée au terrain (si cela concerne des familles entières) on ne pourra pas faire grand-chose car cela est inscrit dans l'ADN de la personne

Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation :

- « Réalisez-vous régulièrement des détartrages ? »
- « Etes-vous la seule personne à avoir des gingivites dans la famille ? »
- « Fumez-vous ? »
- « Etes-vous sous anti-dépresseurs ou anti-épileptique ? »
- « Souffriez-vous de gingivite déjà avant votre grossesse ? »

Ce que l'on peut proposer en préventif :



En allopathie

En naturopathie



OBJECTIF

Limiter l'accumulation de la plaque dentaire dans le but de prévenir la parodontite

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Brossage des dents régulier (2x par jour)• Utilisation de fil dentaire• Détartrage (2X par an) | <ul style="list-style-type: none">• Traitement allopathique• Action sur le terrain (modulation de l'inflammation)• Si tabagisme : accompagnement à l'arrêt du tabac, conseils hygiéno-diététiques et complémentation en vitamine C |
|--|--|

OBJECTIF

Soulager les gencives et limiter les saignements lors du brossage des dents

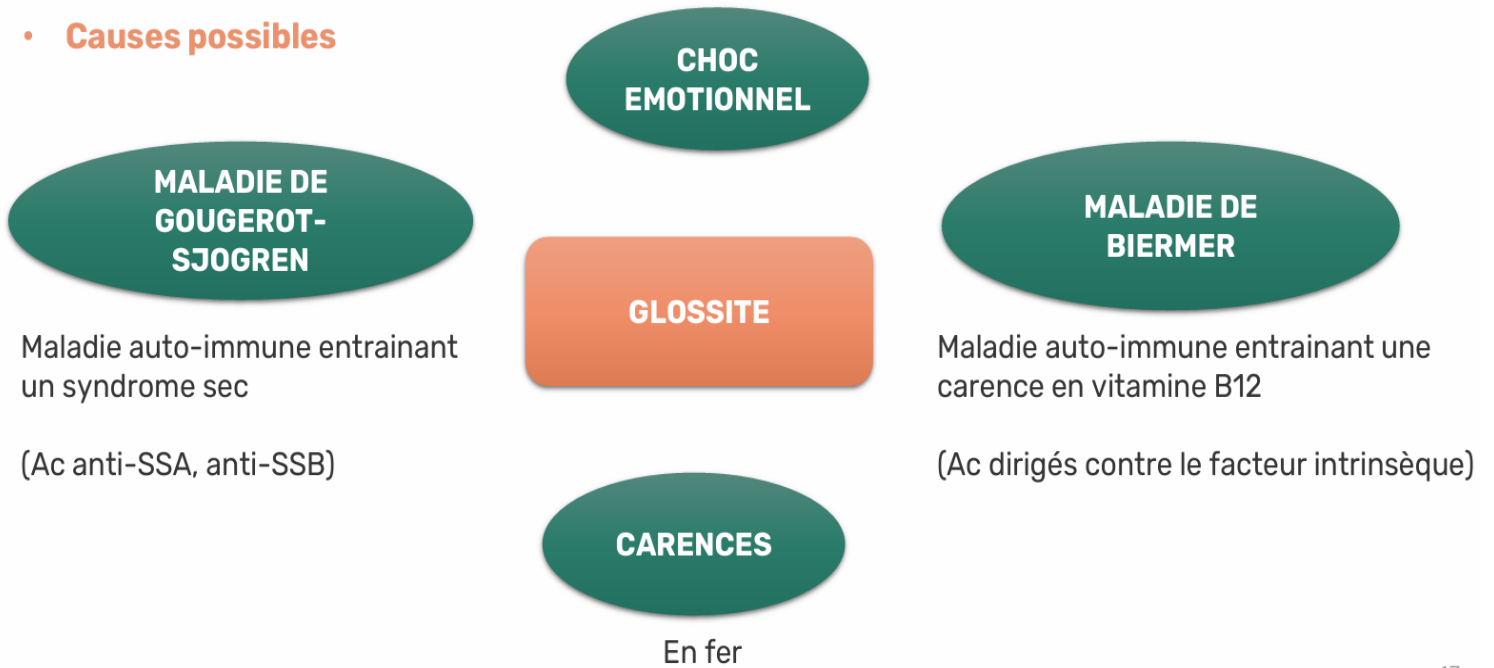
Aromathérapie	Hydrolathérapie	Autre
Nettoyage de la brosse à dent avec de l' HE de tea tree	Bains de bouche avec de l' HA de laurier noble	Dentifrice à base de propolis (RoyalDent par exemple)

HE = huile essentielle

HA = hydrolathérapie

Glossite

• Causes possibles



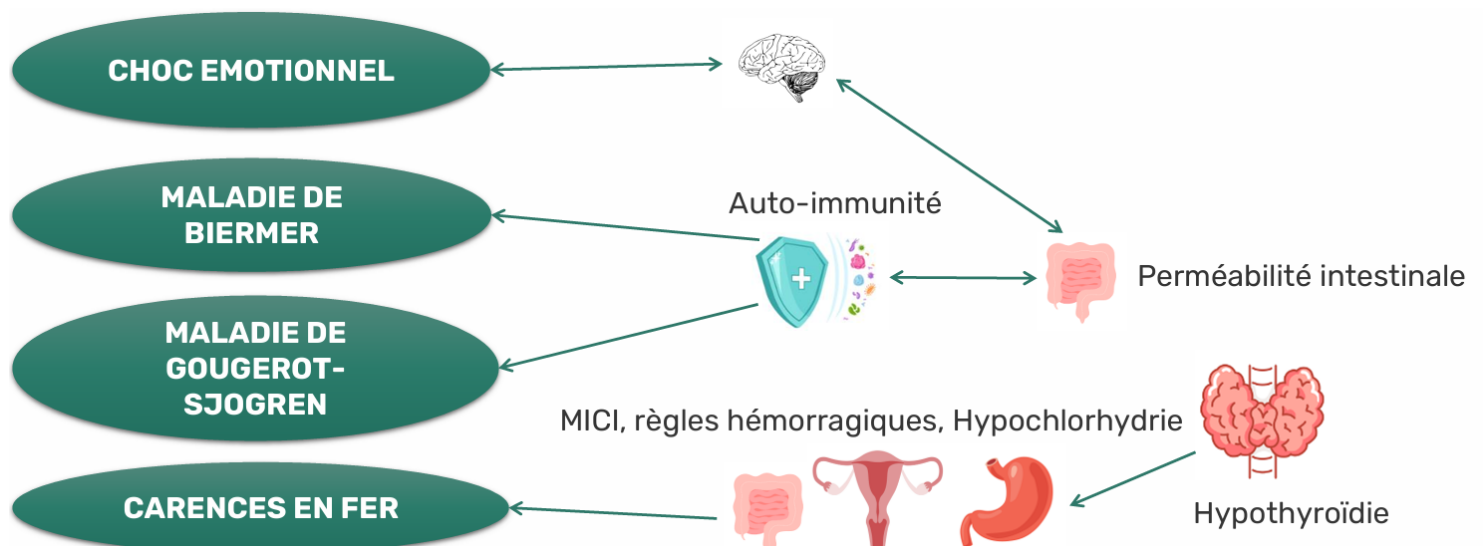
Maladie de Gougerot-Sjogren on a un syndrome sec général c'est-à-dire que tout le corps est en état de sécheresse (cutané, oculaire, vaginale, buccal) et cette sécheresse buccale peut entrainer une glossite

On peut doser les anticorps Anti SSA , et Anti SSB => il serait intéressant de poser la question au consultant

Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation :

- « Y a-t-il des maladies auto-immunes dans votre famille ? »
- « Avez-vous des analyses récentes avec les dosages en ferritine et vitamine B12 ? »
- « Un dosage des anticorps anti-SSA, anti-SSB a-t-il été réalisé? »
- « Faites-vous un lien entre l'apparition de votre glossite et un évènement particulier? »

Menez l'enquête - Les liens entre les systèmes



Le principe fondateur de la naturopathie est le causalisme , un symptôme = une ou plusieurs causes

On partant du schéma si dessus :

1. Imaginons une langue qui n'est pas en bon état :

Cheminement/Réflexions intellectuelles à avoir :

- ⇒ Est qu'il y a eu un choc émotionnel ?
- ⇒ Est-ce que ce choc émotionnel n'a pas provoqué une perméabilité intestinale ?
- ⇒ Est-ce que cette perméabilité n'a pas entrainer de l'auto-immunité ?
- ⇒ Et cette auto-immunité aurait elle entrainer une maladie de Biermer ou de Gougerot ,qui aurait justement entrainer ce symptôme de langue en mauvaise santé ?

2. Ce n'est pas tout de se dire que s'il y a une glossite , est ce que qu'il y a une carence en fer ?

⇒ Chercher la cause de la cause

Cheminement/Réflexions intellectuelles à avoir :

- ⇒ S'il y a des carences en fer, est ce que la personne a une maladie inflammatoire chronique ?
- ⇒ Est-ce que si c'est une femme ,a-t-elle des règles hémorragiques et du coup perd son Fer chaque mois ?
- ⇒ Est-ce que cette personne n'a pas assez de fer car n'a pas assez d'HCL au niveau de son estomac ?
- ⇒ Est-ce que si pas assez d'HCL, cela proviendrait -il d'une hypothyroïdie ?

Menez l'enquête - Les bilans spécialisés recommandés

- Le bilan du statut en acide gras pour évaluer d'une part l'inflammation avec le rapport AA / EPA et d'autre part la sécheresse des muqueuses avec notamment le taux d'acide palmitoléique
- La zonuline pour évaluer la perméabilité intestinale
- Le typage lymphocytaire TH1 / TH2 / TH17 / Treg pour évaluer le fonctionnement du système immunitaire

Ce que l'on peut proposer en préventif



En allopathie

OBJECTIF

En naturopathie



Si syndrome de Gougerot-Sjögren : Limiter le syndrome sec

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Corticoïdes, immunosuppresseurs, sialagogues augmentant la production de salive (Pilocarpine), collyres | <ul style="list-style-type: none">• Modulation de l'inflammation• Modulation du système immunitaire avec la phytothérapie : astragale, curcuma, réglisse, sureau (pour augmenter les TReg). Incompatible avec la prise d'immunosuppresseurs• Renforcement de la barrière intestinale• Complémentation en Oméga 7 (huile d'argousier) |
|--|--|

Ce que l'on peut proposer en préventif



En allopathie

OBJECTIF

En naturopathie



Si maladie de Biermer : Maintenir un taux de B12 stable dans le temps pour éviter l'anémie

- **Injection de vitamine B12** par voie intra-musculaire jusqu'à correction de l'anémie puis une fois par mois, à vie. Surveillance de l'estomac par fibroscopie tous les 2 ans.

- **Aucun accompagnement possible. Réservé à l'allopathie**



En allopathie

OBJECTIF

En naturopathie



Si carence en fer : Combler la carence

- **Complémentation en fer** : Ferrostrane, Tardyferon

- Complémentation en fer : bisglycinate de fer, picolinate de fer, lactoferrine

Peut parfois causer des désagréments digestifs

Comprendre l'origine de la carence : micro-hémorragies internes liées au port du stérilet, règles hémorragiques, MICI, hypochlorhydrie,...

Combinaison LACTOFERRINE + BIGLYCINATE DE FER fonctionne plutôt bien pour remonter les carences en fer (le lactoferrine seul , ne sert pas à grand-chose) mais combiner , permet d'améliorer l'absorption du fer

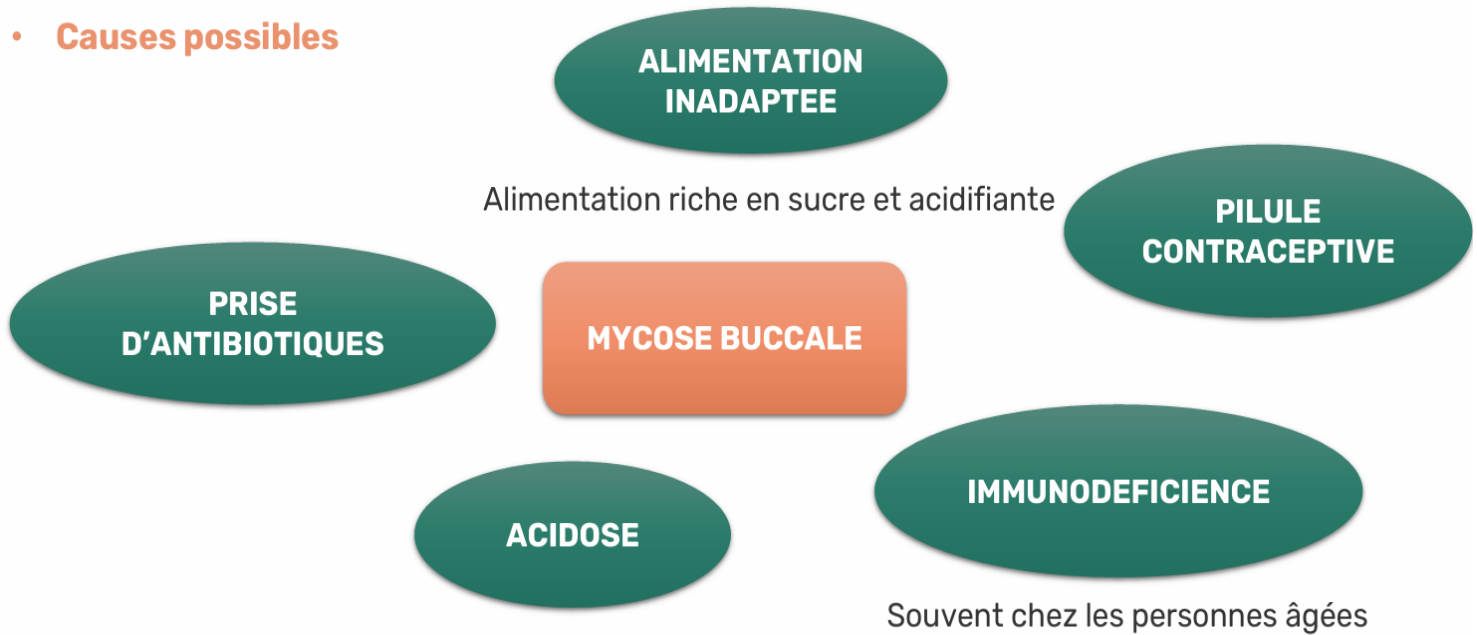
Ce n'est pas tout de compléter en fer parce que dans le cas d'une personne avec des règles hémorragiques , cela ne fonctionnera pas du tout .

⇒ **Il faudra d'abord accompagner cette personne pour qu'elle ait des règles moins hémorragiques**

Candidose buccale

Mycose buccale

- **Causes possibles**



Mycose buccale lié a ce champignon(candida) qui se développe dans des conditions bien précises :

⇒ **Alimentation non adaptée et surtout riche en sucre et acidifiante**

Facteurs aggravant :

- ⇒ prise d'antibiotiques
- ⇒ pilule contraceptive
- ⇒ immuno- déficiences : mycose buccale apparait aussi quand on a un système immunitaire déficient

EX : Le Muguet = chez les bébés , peuvent souffrir de cette maladie que l'on retrouve sur la surface de la langues car leur système immunitaire n'est pas encore bien consolidé

Immunodéficiência aussi chez les personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli ,plus fragile

Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation

- « Avez-vous pris des antibiotiques récemment ? »
 - « Quel est votre rapport au sucre ? »
 - « Etes-vous sous pilule contraceptive ? »
 - « Souffrez-vous de mycoses vaginales, unguéales ? »
- ⇒ **Partez à la recherche d'éventuels signes d'acidification de l'organisme** : arthrose, calculs rénaux, eczéma sec, psoriasis , ... signes qui peuvent alerter sur le niveau d'acidification de la personne
- ⇒ **Partez à la recherche d'éventuels troubles digestifs** pour faire un lien éventuel avec une mycose digestive. => **Car effectivement s'il y a une mycose vaginale ou buccale** (zones facilement visibles et détectables,qu'on peut ressentir a la différence de la mycose digestive) c'est qu'il y a très probablement une mycose digestive
- ⇒ **Il faut parfois aller chercher la mycose digestive si elle bien présente par des analyses justement.**

Menez l'enquête - Les bilans spécialisés recommandés

Si troubles digestifs :

- **Microbiote intestinal et en particulier métabolites fongiques**



- **La zonuline** pour évaluer la **perméabilité intestinale**

Module fongique (analyse d'urine)

En rouge : ce sont tous les métabolites que va sécréter le candida et qui vont être excrétés par l'urine . Cela nous permet de savoir s'il y a une flore fongique en excès au niveau du colon et si candidose ou non

Autre analyse : la zonuline

Dans le cas où il n'y a pas de signe de mycose buccale ou vaginal, ni au niveau des ongles, mais qu'il y a peut être simplement une mycose digestive qui ne se voit pas .La zonuline permet d'évaluer la perméabilité intestinale

Ce que l'on peut proposer en préventif

Ce que l'on peut proposer en préventif



En allopathie

OBJECTIF

Eradiquer localement le champignon

- **Bains de bouche antiseptiques**
- Antifongique local (Gel ou pastilles) contenant des antifongiques comme la **nystatine, l'amphotéricine ou le miconazole**
- Antifongique par voie orale : **kétoconazole ou fluconazole**

Risque important de rechute

En naturopathie

OBJECTIF

Eviter les récides en rééquilibrant le terrain (action sur l'hygiène de vie et les facteurs favorisants)



- **Si lié à une prise d'antibiotiques**, traiter la candidose au niveau digestif
- **Si lié à une prise de pilule contraceptive**, trouver une alternative n'entraînant pas de modification hormonale (préservatif, symptothermie)
- **Si alimentation inadaptée ou acidose**, corriger l'alimentation. Aller vers une alimentation antifongique, alcalinisante et pauvre en sucre...

- **Comment corriger l'acidose avec l'alimentation ?**

- ⇒ **Aliments favorisant la candidose**

- = Aliments acidifiants + Aliments riches en sucre + Aliments fermentés (Choucroute, Kéfir, Kombutcha, produits lactofermentés) + champignons + fromages à moisissures + pomme de terre

- ⇒ **Aliments freinant la candidose**

- = Aliments alcalinisant + Aliments antifongiques (ail, noix de coco, huile de coco, Lapacho)

Les aliments alcalinisant et acidifiants

Groupes d'aliments	Alcalinisants			Acidifiants		
	Tres	Moyen	Peu	Peu	Moyen	Tres
<i>Fruits</i>	Mûre, Fraise, Framboise, Melon d'eau, Agrumes,	Raisin, Abri-cot, Pomme, Avocat, Banane	Noix de coco	Figue, Datte, Tomate Prune	Canneberge, Grenade	
<i>Légumes</i>	Asperge, Céleri, Légumes verts feuillus, Endive, Chou Frisé, Patate douce	Artichaut, Pomme de terre, Betterave, Brocolis, Chou	Pois mange-tout, Carotte, Concombre, Chou de Bruxelles, Chou-fleur	Pois vert, Pois cassé, Epinard, Poireau, Oignon Échalote		
<i>Viandes, volailles et poissons</i>				Palourde	Saumon, Lapin, Poulet, Foie, Bison, Agneau	Saucisse, Crevette, Homard, Bacon, Hamburger, Steak
<i>Produits laitiers, œufs</i>			Beurre clarifié, Œuf (jaune)	Beurre, Fromage caillé	Fromage cottage, Œuf (blanc)	Camembert, Cheddar, Yogourt
<i>Huiles</i>			Olive, Coco, Foie de Morue, Avocat	Sésame, Canola, Tournesol	Soja	

Groupes d'aliments	Alcalinisants			Acidifiants		
	Tres	Moyen	Peu	Peu	Moyen	Tres
<i>Huiles</i>			Olive, Coco, Foie de Morue, Avocat	Sésame, Canola, Tournesol	Soja	
<i>Noix, graines, légumineuses, épices</i>	Châtaigne, Gingembre, Graine de citrouille, Sel de mer	Poivre noir, Noix de cajou, Ail, Cannelle, Sauce soya	Tournesol, Sésame, Lin, Amande, Noix de macadamia	Fève cuite, Haricots rouges et blancs, Pois chiche	Arachide	Noix, Haricot de soja, Sel de table iodé, Sucre blanc
<i>Pains, céréales, desserts</i>			Gruau, Crousta-de aux pommes & sucre brut, quinoa	Riz brun, Farine de Sarrasin	Pain de blé entier, Pain de seigle, Tortillas de maïs, Semoule de maïs, Tarte aux fruits maison	Croissant, Bagel, Gâteau au chocolat, Craquelin Salé, Tarte aux fruits industrielle
<i>Aliments préparés ou restauration rapide</i>				Mayonnaise	Maïs soufflé, Ketchup, Moutarde	Croustille, Pizza, Sandwich au bœuf, Tacos, Nuggets
<i>Boissons</i>	Eau minérale, Thé au gingembre	Jus de pamplemousse, Jus d'ananas	Jus de pomme, jus de raisin, jus d'orange, Thé vert	Lait, Kéfir, Thé noir, Jus de tomate	Vin, Bière brune, Café, Boisson de riz	Bière blonde, Café expresso, Boissons gazeuses, Boissons de soja

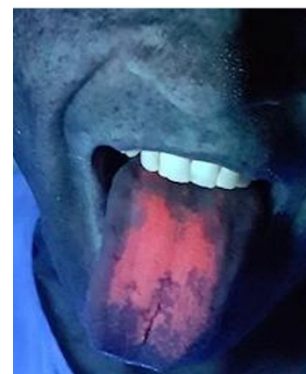
OBJECTIF

Rééquilibrer la flore buccale

Complémentation	Autre
Probiotiques Pileje Lactibiane Buccodental	Nettoyer la langue avec un gratte-langue ou des bains de bouche à l'huile de coco

Technique d'analyse de la langue

- Possibilité d'analyser la langue avec **la lampe de Wood** pour en savoir plus sur la flore buccale (cf. travaux du Dr DONATINI).
⇒ Vidéo Youtube : « La bouche, miroir de votre santé »
- Il est important aussi de demander au consultant s'il a des **amalgames dentaires** afin de faire des liens avec **les symptômes évoqués et les métaux lourds**. Orienter si besoin vers **un dentiste holistique**.



Parfois il y a des symptômes un peu étrange du type fibromyalgie ou fatigue chronique a répétition

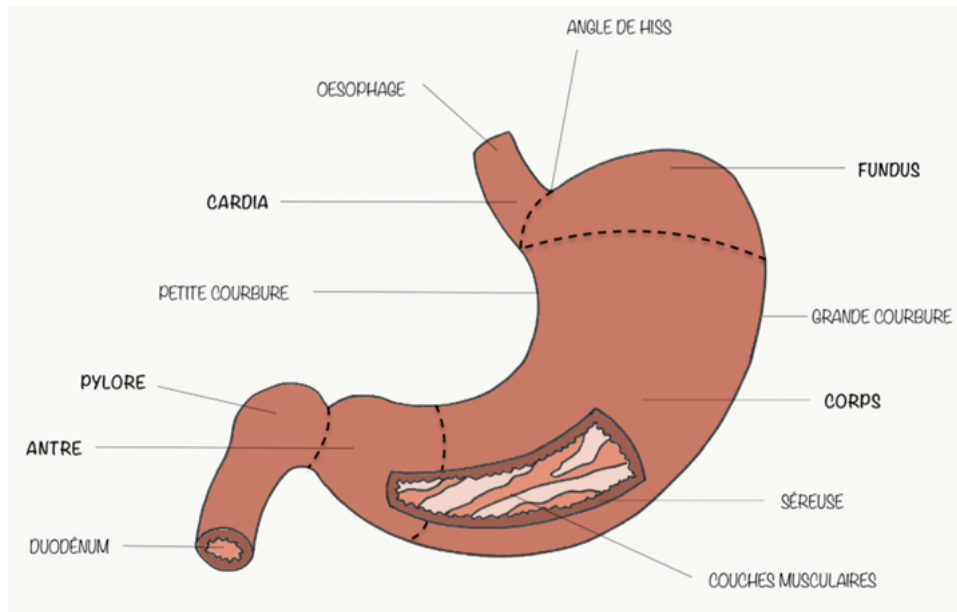
Donc la bouche en dit long sur l'état de notre système digestif et reflète pas mal de choses , et très souvent délaissée. Ne pas hésiter a poser toutes les questions nécessaires a notre consultant

<https://www.chrononutrition.ch/analyse-des-gaz-expir%C3%A9s/la-lampe-de-wood/>

Reflux gastro-œsophagien (RGO), gastrite chronique

Rappels d'anatomie-physiologie

- L'estomac fait suite à la bouche puis l'œsophage.
- Au niveau de l'estomac, les aliments poursuivent leur dégradation grâce à la digestion chimique et la digestion mécanique.
- Durant la digestion chimique, les aliments sont broyés, malaxés et brassés.
- Lors de la digestion chimique, le pepsinogène est transformé en pepsine sous l'action de l'HCL permettant d'entamer le processus de digestion des protéines.



<https://www.fiches-ide.fr/anatomie-physiologie/estomac/>

Diverses sécrétions ont lieu au niveau de l'estomac :

- **Sécrétion de mucus**
⇒ Permet de protéger la muqueuse gastrique
- **Sécrétion d'HCl**
⇒ L'HCl a une fonction bactéricide
- **Sécrétion du facteur intrinsèque**
⇒ Permet l'absorption de la vitamine B12
- **Sécrétion de gastrine**
⇒ Permet la régulation de la sécrétion acide

Substances sécrétées par l'estomac et fonctions dans la digestion chimique

digestion chimique			fonction
hormones	enzymes	autres	
Cellules G → gastrine	<i>stimule les glandes gastriques pour produire</i> Cellules principales → lipase gastrique → proenzyme pepsinogène ↓ enzyme pepsine (active)	Cellules caliciformes → mucus visqueux et alcalin Cellules pariétales ou bordantes : → facteur intrinsèque → HCl ← active	- nourriture dans la bouche et PH acide de l'estomac => production de gastrine stimulant les glandes gastriques pour produire : - pepsinogène (précurseur de la pepsine) - mucus (protection des parois de l'estomac) - HCl (déstructuration des protéines, protection/bactéries) pepsine : protéase, amorce la digestion des protéines → peptides (<50 AA) lipase gastrique : rôle majeur pour le nouveau-né dont l'alimentation est particulièrement riche en lipides (lait) facteur intrinsèque : permet l'absorption de la vitamine B12 dans l'intestin grêle suc gastrique : ensemble des sécrétions (1,5 à 2 l/jour)

Définitions

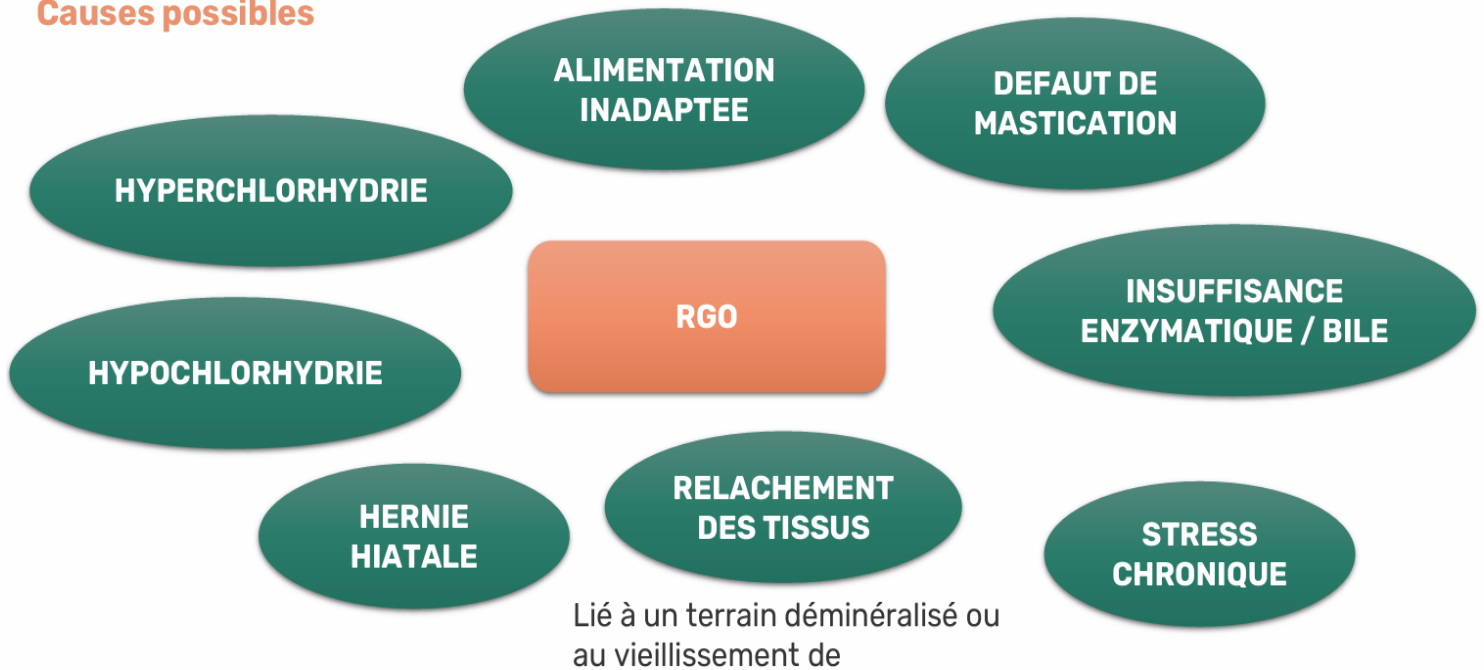
	REFLUX GASTRO-OESOPHAGIEN (RGO)	GASTRITE CHRONIQUE	HERNIE HIATALE
Définition / Symptômes	Régurgitation du contenu acide de l'estomac dans l'oesophage. Sensation de brûlure au creux de l'estomac irradiant derrière le sternum. La douleur survient souvent après les repas.	Inflammation de la muqueuse de l'estomac.	Poche formée par la partie supérieure de la grande courbure de l'estomac qui passe par le trou œsophagique du diaphragme (hiatus œsophagien). Asymptomatique ou RGO entraînant brûlures œsophagiennes, remontées acides, douleurs à l'abdomen, régurgitations alimentaires, éructations, hoquet, nausées, toux.
Evolution possible / Risques	Œsophagite petique avec risque d'endobrachyoesophage.	Douleurs gastriques (brûlures d'estomac) déclenchées ou exacerbées par la prise de certains aliments .	Oesophagite et sténose de l'oesophage, cancer de l'œsophage.
Diagnostic	Sur la clinique et fibroscopie si besoin.	Sur la clinique et fibroscopie si besoin.	Fibroscopie + radiographie pulmonaire.

Il est possible d'avoir a la fois un RGO et une gastrite et dans ce cas il faudra bien poser la question :

⇒ Est-ce que vous avez des douleurs au niveau de l'œsophage ou c'est localisé au niveau de l'estomac ?

Hernie Hiatale : Il y a une excroissance qui va se développer au niveau du hiatus œsophagien (l'orifice par lequel passe l'œsophage a travers le diaphragme)qui va entrainer un encombrement et parfois va lever le clapet de l'estomac qui empêche l'HCL de remonter . C'est pour cela que la hernie hiatale peut entrainer des RGO

Causes possibles



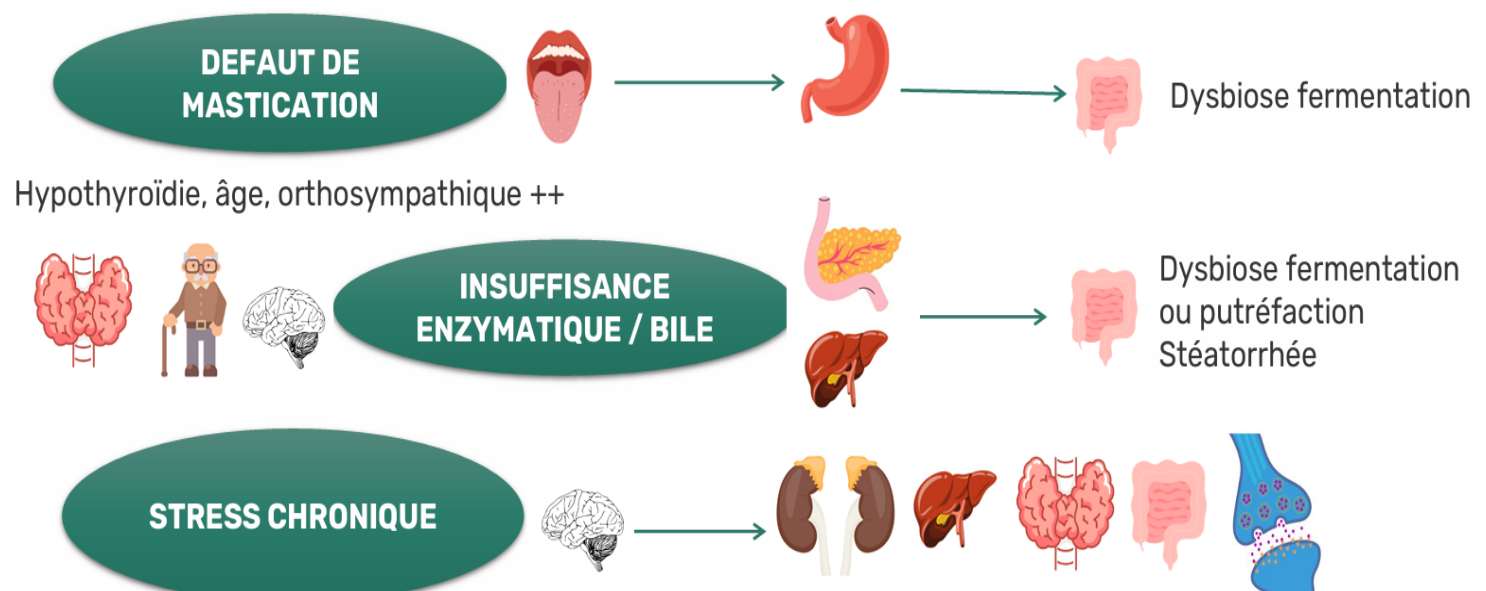
Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation

- « Prenez-vous le temps de manger ? »
- « Faites-vous un lien entre vos symptômes et une situation de stress ? »
- « Avez-vous des sensations de brûlure dans l'estomac ou uniquement du reflux ? »
- « Avez-vous réalisé une fibroscopie ? »
- « Votre médecin vous a-t-il prescrit un traitement pour votre reflux (IPP) ? »
- « Vos symptômes se déclenche-t-il avec des aliments spécifiques ?

(FODMAPS, aliments irritants comme le piment, l'alcool, le café) »

- « Le reflux survient-il plutôt avant ou après le repas ? »

Menez l'enquête - Les liens entre les systèmes



On partant du schéma si dessus :

1. Si vous vous apercevez que la personne a plutôt une dysbiose de fermentation

Cheminement/Réflexions intellectuelles a avoir :

⇒ Remonter en amont et voir si cette dysbiose est liée a un défaut de mastication

2. Si dysbiose de putréfaction

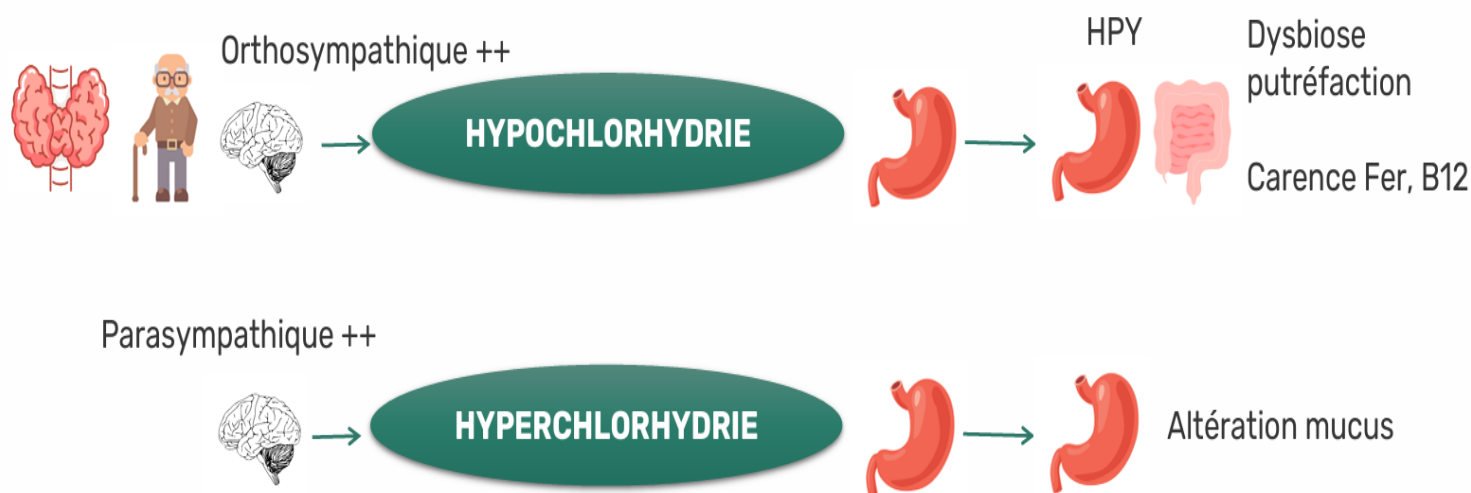
Cheminement/Réflexions intellectuelles a avoir :

- ⇒ Remonter en amont et voir si cette dysbiose serait liée à une insuffisance enzymatique
- ⇒ Est-ce que se serait lié à un système orthosympathique trop important ? Donc c'est-à-dire du stress qui peut couper les sécrétions
- ⇒ Est-ce que c'est lié à l'âge ? Car avec l'âge ,moins de production enzymatique de manière générale
- ⇒ Est-ce lié à une hypothyroïdie car on a de moins en moins de sécrétions

3. En cas de stress chronique , comment cela va influencer ces autres systèmes ?

- ⇒ Souvent les systèmes les plus impactés par le stress ce sont les surrénales ,le foie, la thyroïde, les intestins, et la production de neurotransmetteurs

Il y a un symptôme a la base mais aussi tout ce qu'il y a autour avec les autres systèmes



On partant du schéma si dessus :

1. Si une personne a une hypochlorhydrie, qu'est que ça impacte ? Si elle manque d'HCL ?

Cheminement/Réflexions intellectuelles a avoir :

- ⇒ Est-ce que c'est lié au stress ? Parce que le stress coupe toutes les sécrétions
- ⇒ Est-ce que c'est une personne âgée qui ne produit pas assez d'HCL ?
- ⇒ Est qu'il y a une thyroïde en hypo ?
- ⇒ L'HCL est bactéricide et donc en hypo ,elle favoriserait l'HPY et/ou dysbiose de putréfaction car les protéines seront mal digérées et vont entrainer des gaz malodorants
- ⇒ Donc la dysbiose de putréfaction est directement lié a un manque d'HCL

2. Dans le cas d'une hyperchlorhydrie , le parasympathique prend le dessus(plus rare)

- ⇒ Souvent lié à une telle crispation interne, que le système nerveux va ouvrir toutes les vannes . C'est-à-dire que la personne va avoir des diarrhées, sécréter énormément d'HCL
- ⇒ Un parasympathique qui est en hyperfonctionnement c'est très souvent lié à une crispation hyper importante et génère une hyperchlorhydrie qui va altérer la muqueuse de l'estomac et attaquer le mucus.

Menez l'enquête - Les bilans spécialisés recommandés

- Le **FUT-2** pour évaluer la qualité du mucus
- Les **acides biliaires** pour évaluer la qualité de la bile

Ce que l'allopathie propose :



En allopathie

OBJECTIF

Soulager les brûlure épigastriques en abaissant l'acidité de l'estomac et en protégeant la muqueuse gastrique

- 1^{ère} intention : Conseils hygiénodietétiques + **Pansements gastriques (Gaviscon)**
- 2^{ème} intention : **Médicaments anti-acides** (IPP = inhibiteurs de la pompe à protons)
- Exemples d'IPP : Lansoprazole, Oméprazole, Rabéprazole, Esoméprazole, Pantoprazole
- En cas d'échec du traitement : technique chirurgicale consistant à créer une valve anti-reflux entre œsophage et estomac

Ce que l'on peut proposer en naturopathie en préventif :

En naturopathie



OBJECTIF GENERAL :

Comprendre l'origine du RGO et rééquilibrer le terrain en corrigeant les erreurs d'hygiène de vie et en soutenant la digestion

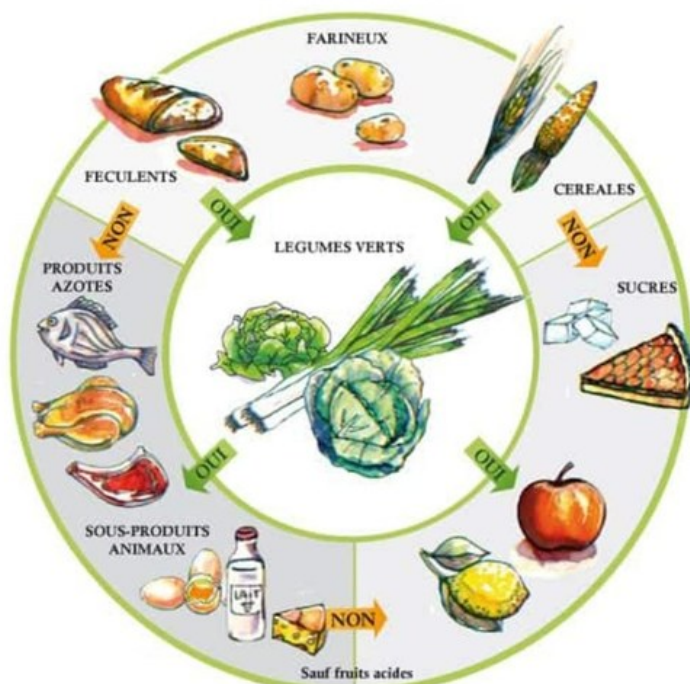
- Si l'alimentation est inadaptée et la mastication insuffisante

SOUS-OBJECTIF : Corriger l'alimentation et améliorer la digestion

- **Alimentation dissociée et/ou pauvre en FODMAPS** en fonction des symptômes évoqués par le consultant
- Manger **lentement** et **à distance du coucher**
- Surélever **la tête avec un oreiller le soir**

	Pauvre en FODMAP	Riche en FODMAP
Viande, volaille, poisson, œufs	Bœuf, poulet, thon en conserve, œufs, poisson, agneau, porc, crustacés, dinde, viande froide	Plats cuisinés avec des ingrédients riches en FODMAP ou en sirop de maïs à haute teneur en fructose
Laitages	Lait et yaourts sans lactose, beurre, fromages à pâte dure, brie, camembert	Lait de vache, de brebis, de chèvre. yaourts, crème anglaise, crèmes glacées, fromage blanc... Chocolat, fromages à pâte molle
Céréales	Avoine, épeautre, riz, tapioca, quinoa, maïs	Produits à base de blé et de seigle
Fruits	Banane, baies, raisin, kiwi, fraise, kumquat, citron, mandarine, clémentine, orange, fruit de la passion, ananas, rhubarbe, melon	Pomme, abricot, date, cerise, framboise, goyave, lychee, mangue, nectarine, pêche, poire, figue, prune, kaki, pastèque, fruits en conserve, fruits secs,
Légumes	Poivron, aubergine, concombre, carotte, céleri, maïs, laitue, haricot vert, pomme de terre, tomate, courgette, olive	Artichaut, avocat, asperge, betterave, poireau, brocoli, chou, chou de Bruxelles, chou-fleur, fenouil, céleri, champignon, pois mange tout,
Boissons	Café, thé, jus de fruits pauvres en FODMAP	Boissons à base de sirop de maïs à haute teneur en fructose, jus de fruits riches en FODMAP, vins fortifiés (sherry, marsala...)
Assaisonnements et condiments	La plupart des épices et herbes, bouillon fait maison, ciboulette, ail, huile d'olive, vinaigre, vinaigre balsamique, poivre, sel, sucre	Ail, oignons, miel, confiture, gelée, cacao en poudre, produits à base de légumes ou fruits à haute teneur en FODMAP, chutneys, édulcorants artificiels : sorbitol, mannitol, isomalt, xylitol inuline
Noix et graines	Amande (en petite quantité), graine de potiron	Noix de cajou, pistache,

LES BONNES COMBINAISONS ALIMENTAIRES



- Si le consultant exprime un lien direct entre son RGO et des situations de stress
 - ⇒ **SOUS-OBJECTIF : Limiter le stress**
 - ⇒ Proposer des techniques de gestion du stress.
- Si le consultant a des signes de déminéralisation
 - ⇒ **SOUS-OBJECTIF : Reminéraliser**
 - ⇒ Proposer des aliments riches en minéraux : algues, cru, herbes aromatiques, plasma de Quinton.

Comment évaluer si le consultant est en hypochlorhydrie ou hyperchlorhydrie ?

- Faire le test du bicarbonate de soude (pas fiable a 100%)
- Faire le test au lever, l'estomac vide. (Ne pas prendre de traitement sinon cela va fausser les résultats)

Dissoudre 1/4 de c-à-café de bicarbonate de soude dans un verre d'eau ;

- ⇒ Boire et démarrer un chronomètre ;
- ⇒ Arrêter à la première éructation et noter le temps écoulé.



Bicarbonate + HCL (estomac) = CO2

- ⇒ Au plus on a d'HCL, plus l'éructation (renvoi) est puissante et arrive rapidement.
- ⇒ Expliquez au consultant que le bicarbonate va réagir avec l'HCL de l'estomac pour former un gaz doux = CO2

Avant 1 min : Hyperchlorhydrie

Entre 1 et 2 min : Pas de déséquilibre

Après 2 min : Hypochlorhydrie probable

Après 5 min : Hypochlorhydrie quasi certaine

- Si le consultant est en hypochlorhydrie (fréquent) : le consultant a souvent des douleurs après les repas dans ce cas-là.

SOUS-OBJECTIF : Comprendre l'origine de l'hypochlorhydrie et augmenter la sécrétion d'HCl

- Si le consultant est sous IPP, lui expliquer que les IPP vont favoriser son hypochlorhydrie mais ne pas lui dire de les arrêter pour autant. Lui proposer des analyses pour comprendre pourquoi il est hypochlorhydrie et ce que cela implique sur sa digestion.
- Boire le moins possible durant les repas pour ne pas diluer les **sécrétions gastriques**.
- S'il n'est pas sous IPP, Proposer un complément d'HCl.

⊘ **Contre-indiqué en cas d'ulcère gastrique.**



- **Si le consultant est en hyperchlorhydrie (plus rare) :** Le consultant a souvent des douleurs avant les repas dans ce cas-là.

SOUS- OBJECTIF : Comprendre l'origine de l'hyperchlorhydrie et diminuer la production d'HCl et protéger la muqueuse gastrique

- Les **IPP** sont fortement recommandés ou en alternative le **bourgeon de figuier** (draineur estomac, régulateur HCl, cicatrisant).
- **Argile** par voie orale. **Attention, peut provoquer de la constipation.**
- Jus de pomme de terre crue.
- **Jus d'aloe vera** par voie orale entre les repas.



Comment évaluer si le consultant manque d'enzymes digestives ?

Si la prise d'enzymes digestives provoque un mieux-être ou par une analyse du type Coproscreen mais c'est une analyse assez coûteuse.

CONCLUSION DE L'EXAMEN PHYSIQUE DES SELLES

Fonctions motrices :

Le transit paraît être alterne : alternance de périodes où le transit est sensiblement accéléré (avec ou sans diarrhée) avec des périodes où le transit est plus ralenti (avec ou sans constipation).

Troubles vaso-sympathique probable de la motilité intestinale.

Fonction gastrique :

La digestion reste limite.

Une mastication suffisante et efficace permettrait de limiter ces phénomènes.

Fonction hépatobiliaire :

La digestion reste correcte.

Fonction pancréatique lipidique :

La digestion reste limite. L'origine ou les origines des anomalies biologiques retrouvées peut ou peuvent être diverses et multiples et doit ou doivent être recherchée(s) en fonction de la clinique et des prises médicamenteuses du patient : – Insuffisance de sécrétions en lipase pancréatique. – Excès d'apports alimentaires en acides gras saturés et/ou polyinsaturés. – Médications grasses (laxatifs,...). A corréler à la clinique.

Fonction pancréatique protéique :

La digestion reste limite. L'origine ou les origines des anomalies biologiques retrouvées peut ou peuvent être diverses et multiples et doit ou doivent être recherchée(s) en fonction de la clinique et des prises médicamenteuses du patient : – Vidange gastrique un peu rapide.

– Défaut de mastication. – Insuffisance en trypsine pancréatique. A corréler à la clinique.

Extrait d'un résultat de l'analyse Coproscreen du laboratoire BARBIER

Ce que l'on peut proposer en naturopathie en préventif

- **Si le consultant est en insuffisance enzymatique ou biliaire :**

SOUS-OBJECTIF : Relancer la fonction pancréatique et biliaire dans le but de soutenir la digestion

- Plantes amères (gentiane, l'artichaut ou le radis noir) pour **augmenter les sécrétions de sucs digestifs**
- Complémentation en **enzymes digestives**



Ingrédients par comprimé

HCl de bétaïne	155 mg
Pepsine	315 FCC
Pancréatine (mélange d'amylase 9600 USP, lipase 800 USP, et Protéase 9600 USP)	
Acide L-Glutamique HCl	100 mg
Lipase	7500 FCC
Papaïne	22,5 FIP
Amylase	990 FCC
Bromelaïne	120 FIP

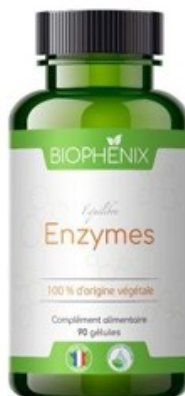


Bromélaïne extraite de tige d'ananas *Ananas comosus* (L.) Merrill,

complexe d'enzymes digestives : **amylase***, **phytase**, **lactase**, **lipase***, **protéase***, **cellulase**, **diastase**,
enveloppe de la gélule végétale : pullulan,
Tolerase-G® : **prolyl-oligopeptidase**,
sels calciques de l'acide citrique.

*issues de champignon

Tolerase-G® est une marque commerciale de DSM.



Ingrédients

- Extrait sec d'orge, malt (*Hordeum vulgare*) - (Belgique)
- Cellulase (*Aspergillus niger*) - (non UE)
- Lactase (*Aspergillus Oryzae*) - (non UE)
- Lipase (*Thermomyces lanuginosus*) - (non UE)

Enveloppe de la gélule d'origine végétale :
Hydroxypropylméthylcellulose

Garanti sans gluten

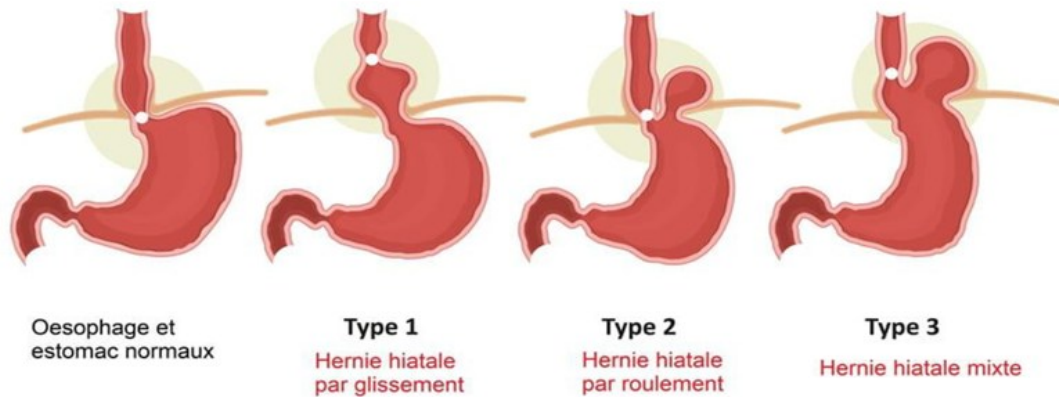
Composition nutritionnelle pour 3 gélules

Extractions intégrales* aqueuses issues de

- Orge, sans gluten 1050 mg dont :

- Amylase 840 mg
- Phytase 105 mg
- Protéase 105 mg
- Cellulase 150 mg
- Lactase 150 mg
- Lipase 150 mg

TYPES DE HERNIES HIATALES



Cause inconnue mais **l'obésité** est un facteur favorisant

Le RGO est une conséquence fréquente de la hernie hiatale.

<https://sante.journaldesfemmes.fr/fiches-maladies/2513846-hernie-hiatale-glissement-roulement-symptome-cause-traitement-operation/>

Ce que l'on propose :



En allopathie

OBJECTIF

Si RGO, soulager les brûlures épigastriques en diminuant l'acidité gastrique

- Voir accompagnement du RGO en allopathie
- Intervention chirurgicale si le RGO est trop important

En naturopathie

OBJECTIF

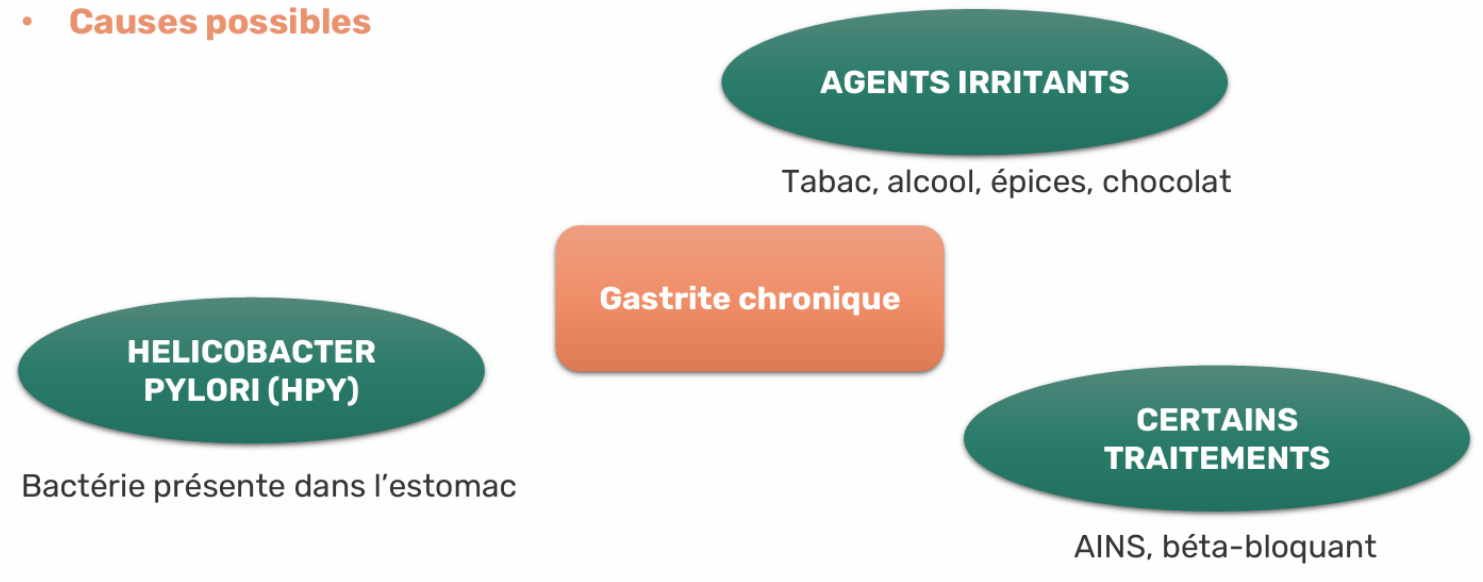
Si RGO, soulager les douleurs épigastriques en corrigeant les erreurs d'hygiène de vie et soutenant la digestion

- Voir accompagnement du RGO en naturopathie



Gastrite chronique

- **Causes possibles**



Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation

Mêmes questions que pour le RGO et en plus :

- « Votre médecin vous a-t-il prescrit une analyse pour évaluer la présence de l'HPY ? »

Comment évalue-t-on la présence d'HPY ?

- ⇒ **Fibroscopie ou moins invasif** : prise de sang, recherche d'antigènes dans les selles, test respiratoire.

Ce que l'allopathie propose :

 En allopathie	OBJECTIF Soulager les brûlures gastriques en abaissant l'acidité de l'estomac et en protégeant la muqueuse gastrique • 1^{ère} intention : Conseils hygiénodietétiques + Pansements gastriques (Gaviscon). • 2^{ème} intention : Médicaments anti-acides (IPP = inhibiteurs de la pompe à protons). • Exemples d'IPP : Lansoprazole, Oméprazole, Rabéprazole, Esoméprazole, Pantoprazole. • En cas d'HPY : Antibiotiques + IPP.
---	---

Ce que l'on peut proposer en naturopathie en préventif :

En naturopathie



OBJECTIF GENERAL

Comprendre l'origine de la gastrite, corriger les erreurs d'hygiène de vie, soutenir la digestion

- Si le consultant consomme des agents irritants :

L'accompagner à l'arrêt du tabac et/ou de l'alcool (recommandation hypnose, acupuncture, kudzu,...) et des aliments irritants pour la muqueuse gastrique (épices, chocolat,...)

- Si le consultant exprime un lien direct entre ses douleurs gastriques et des situations de stress :

Proposer des techniques de gestion du stress

- Si l'HPY est présent :

SOUS-OBJECTIF : Eradiquer l'HPY

Consommation d'aliments riches en sulforaphanes comme le brocoli et le radis noir par ex.

Probiotiques spécifiques contenant de la réglisse : Pileje Lactibiane H-Py.

 Contre-indiqué en cas d'hypertension

Bien expliquer au consultant que les HE sont beaucoup moins efficaces que les antibiotiques.

⇒ Les antibiotiques restent la meilleure option parce que c'est souvent une bactérie assez coriace

Proposer une prise d'huiles essentielles antibactériennes par voie orale : A faire faire à la pharmacie homéopathique de l'Europe.

Formule A :

- **HE lentisque pistachier 20 mg**
- **HE Sarriette 10 mg**
- **HE Thym à linalol 10 mg**
- **Excipient qsp 1 gélule n°30**

⇒ **2 gélules matin + 2 gélules soir** au cours des repas avec **un peu d'huile d'olive pendant 7 jours.**

Tout de suite après :

Formule B :

- **HE Ravintsara 20 mg**
- **HE Niaouli 10 mg**
- **HE Menthe poivrée 10 mg**
- **HE Lavande aspic 10 mg**
- **HE Citron 10 mg**
- **Excipient qsp 1 gélule n° 30**

⇒ **3 gélules par jour (1 matin, 1 midi, 1 soir)** au cours des repas avec **un peu d'huile d'olive pendant 10 jours.**

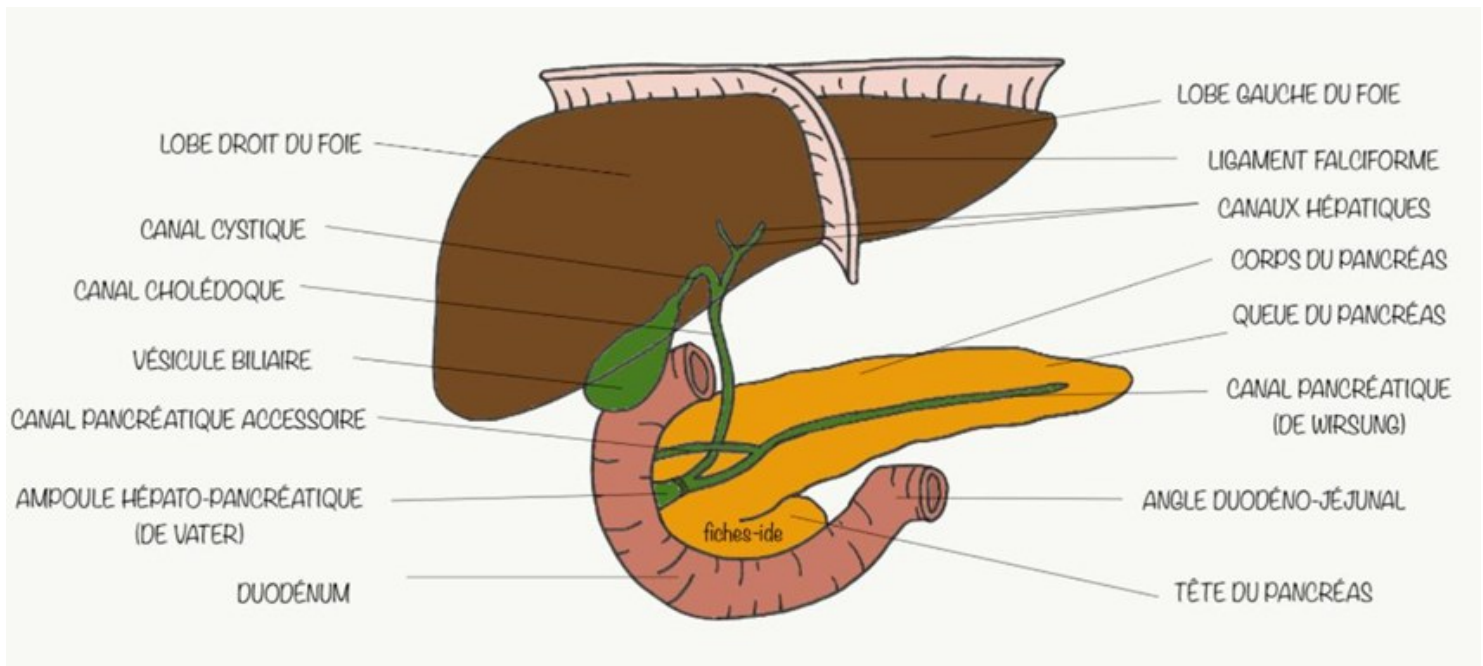
⇒ A prendre au cours des repas avec un peu d'huile d'olive

Insuffisance hépatique, surcharge hépatique

Rappels d'anatomie-physiologie

Rôles du foie :

- **Métabolisme**
 - ⇒ Glucides, lipides (cholestérol, vit D), protéines (albumine)
- **Epuration**
 - ⇒ Destruction hématies usées, neutralisation toxines & hormones, conversion de l'ammoniac
- **Stockage**
 - ⇒ Vitamines A,D,E,K, glycogène, Fer, Cu, B12
- **Digestion**
 - ⇒ Emulsion des graisses (production de bile)



<https://www.fiches-ide.fr/anatomie-physiologie/foie-vesicule-biliaire-duodenum-et-pancreas/>

Rôle de la vésicule biliaire :

- **Emmagasine et concentre la bile**
- **Bile** = Eau + bicarbonates + sels biliaires + lécithine + pigments biliaires
- La bile permet la digestion des lipides

Définitions

	INSUFFISANCE HEPATIQUE	SURCHARGE HEPATIQUE
Définition / Symptômes	Ensemble des manifestations cliniques et biologiques dues à une diminution de la masse des cellules hépatiques. Stade modéré : asthénie, amaigrissement, sensibilité anormale aux médicaments. Stade plus avancé : ictère, somnolence, trouble de l'hémostase, troubles nerveux et endocrinien.	Ensemble des manifestations biologiques dues à une difficulté du foie à exercer sa fonction d'élimination. Acné, migraine, halitose (langue blanche, bouche pâteuse), digestion lente et difficile surtout pour les graisses (selles grasses et flottantes).

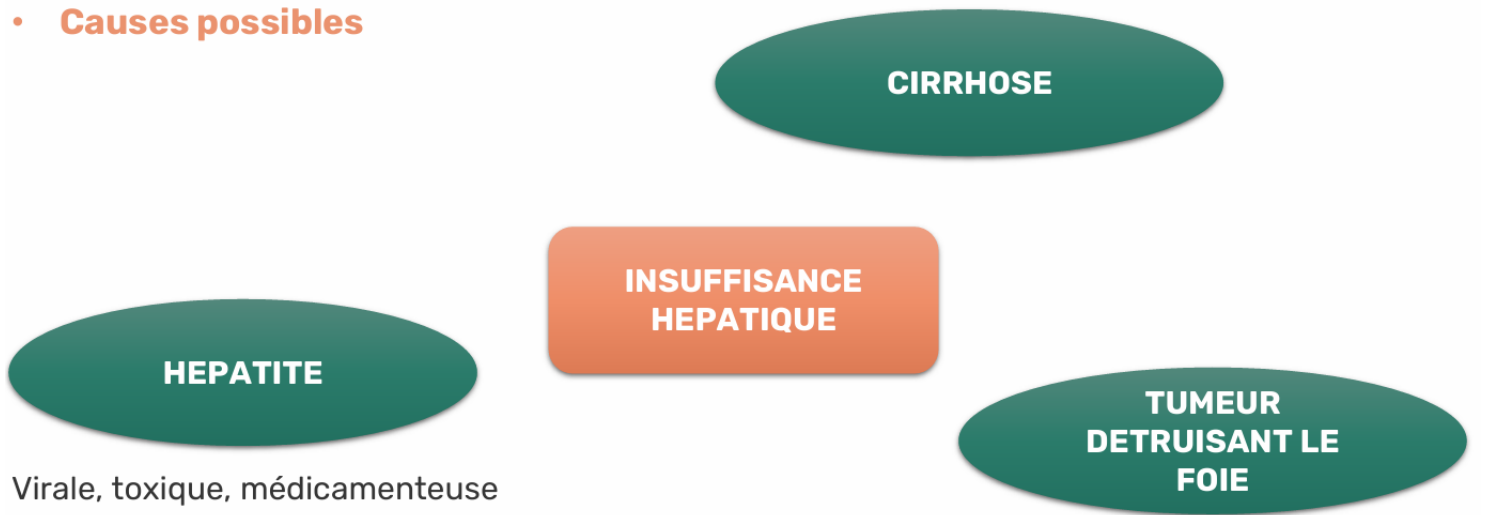
L'insuffisance hépatique : relève vraiment de l'allopathie car c'est une pathologie grave ou l'on va avoir une diminution des cellules hépatiques par destruction de celles-ci. Cas grave qui se manifeste par une très grosse fatigue, un amaigrissement, de la somnolence, une peau qui jaunisse. Le corps ne peut pas vivre finalement avec un foie endommagé.

Surcharge hépatique : c'est une notion naturopathique

	INSUFFISANCE HEPATIQUE	SURCHARGE HEPATIQUE
Diagnostic	Dosage des enzymes hépatiques : • Transaminases (ASAT et ALAT) • Gamma GT (GGT) • Phosphatases alcalines (PAL) Dosage de la bilirubine (pigment biliaire) Ces valeurs augmentent lors de la destruction des cellules hépatiques.	La surcharge hépatique ne s'accompagne d'aucunes lésions et n'est pas répertoriée comme une pathologie par l'allopathie. N'est pas détectable par des analyses biologiques.

Insuffisance hépatique

- **Causes possibles**



Ce que l'on propose :



En allopathie

OBJECTIF

Traiter l'hépatite si elle est à l'origine de l'insuffisance hépatique

- Il n'y a pas de médicament pour remplacer la fonction hépatique.
- Seule la **greffe du foie**, quand elle est possible, peut guérir le consultant.

En naturopathie

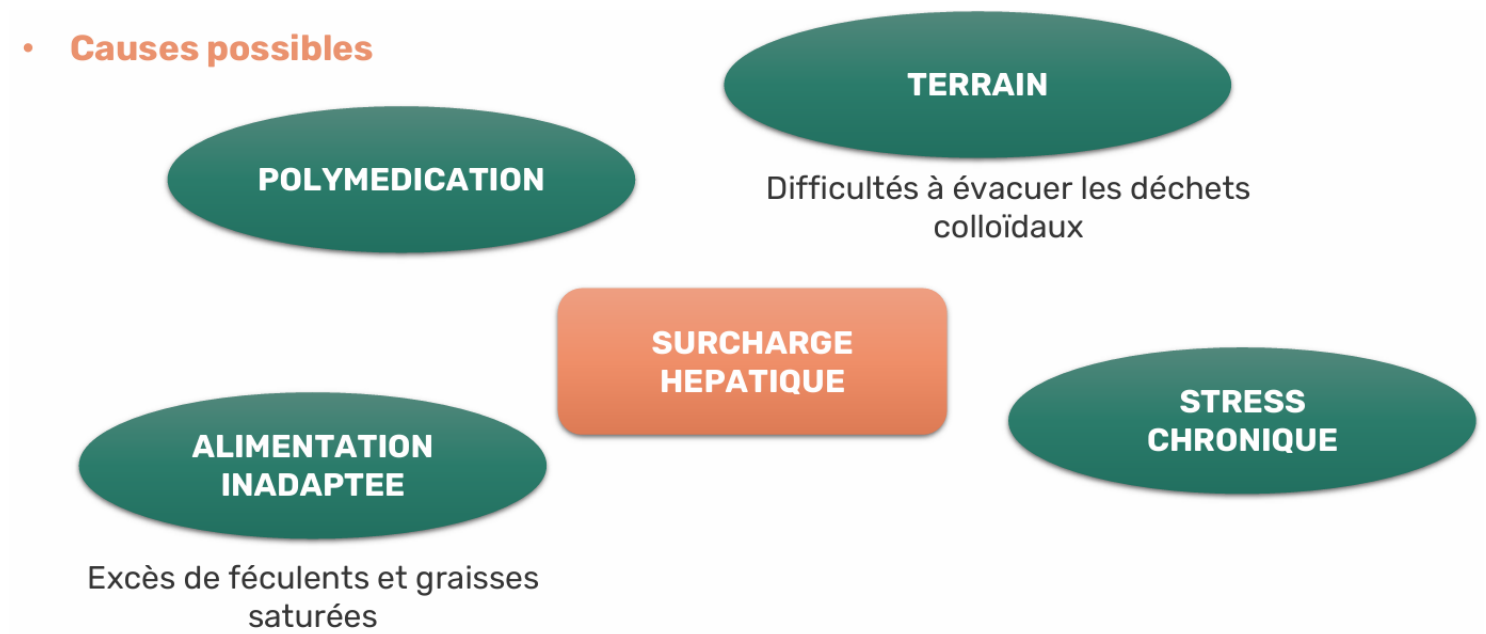


- **Aucun accompagnement possible. Réservé à l'allopathie**



Surcharge hépatique

- **Causes possibles**



Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation

- « Vos selles sont-elles grasses ? »
- « Avez-vous des migraines ? »
- « Avez-vous la langue blanche et pâteuse ou mauvaise haleine ? »
- « Votre peau est-elle grasse, acnéique ? »

Ce que l'on propose :



En allopathie

Pas de traitement car n'est pas considéré comme une pathologie par l'allopathie.

Ce que l'on peut proposer en naturopathie :

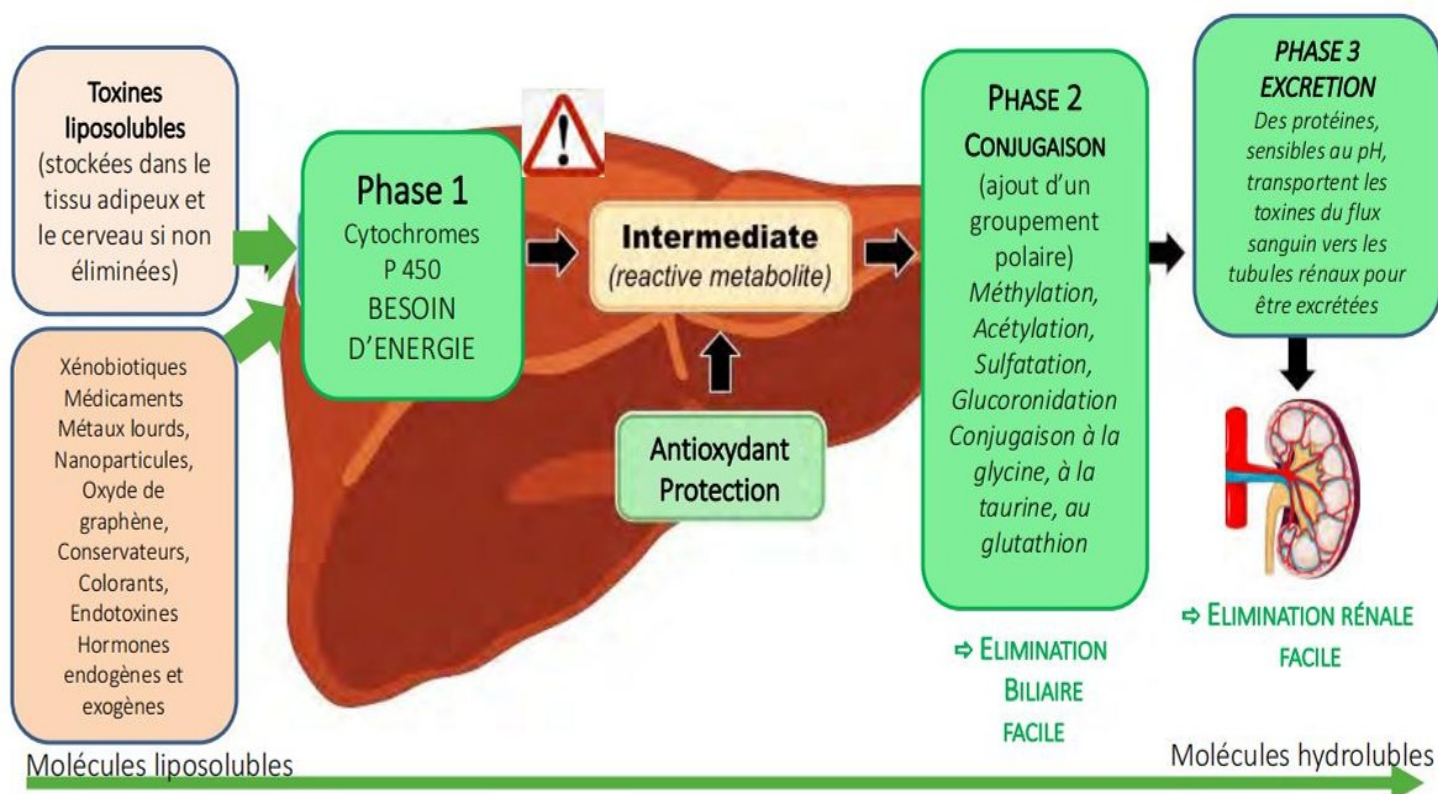
Ce que l'on peut proposer en naturopathie :

OBJECTIF : Stimuler la fonction hépatobiliaire pour favoriser l'élimination des toxines



- Alimentation bénéfique pour le foie : légumes à feuilles vertes, crucifères, navet, romarin, citron, curcuma, radis noir, ...
- Bouillotte ou bain chaud sur le foie après le repas
- Techniques de relaxation
- Phytothérapie (plantes cholagogues et cholérétiques) : Chardon-marie, artichaut, fumeterre, boldo, radis noir, ...
- Aromathérapie voie orale suite à un traitement médicamenteux lourd : Livèche, carotte, romarin à verbénone, Lédon du Groenland, citron

Rappels sur la détoxification hépatique



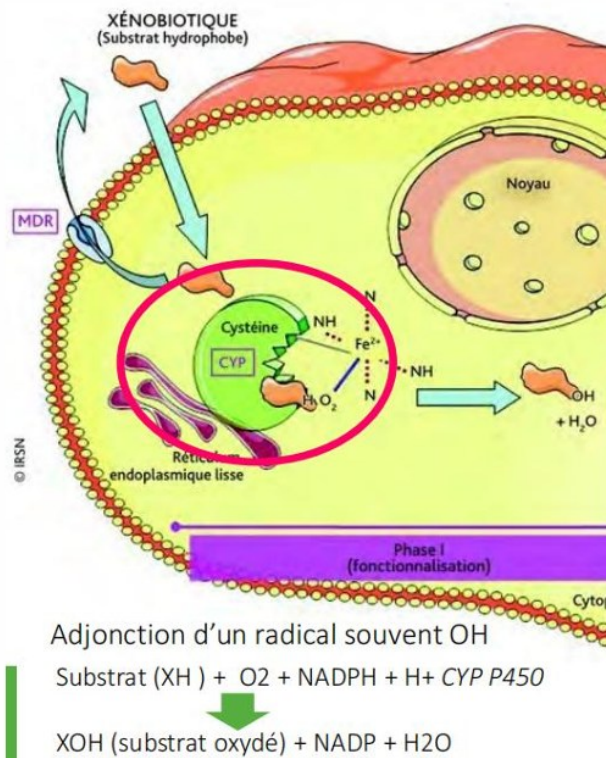
Médicaments et plantes hépatiques

Les médicaments ne sont pas tous métabolisés de la même façon par le foie.

Ce sont les cytochromes et plus précisément les isoenzymes des cytochromes P450 qui vont les éliminer plus ou moins rapidement.

Certaines substances vont induire ou inhiber ces isoenzymes.

- **Les substances inductrices** = substances qui accélèrent l'élimination du médicament (ou substrat) → diminution de l'efficacité de celui-ci.
- **Les substances inhibitrices** = ralentissement de l'élimination du médicament → risques (toxicité).



Avant de préconiser la plante, il faut connaître la voie métabolique d'élimination du médicament, soit l'isoenzyme du cytochrome P450 qui est active pour ce médicament.

Ensuite, il faut regarder les plantes inhibitrices ou inductrices de l'isoenzyme et ne pas les préconiser car risque que le médicament ne soit plus efficace ou risque qu'il devienne toxique ou dangereux.

Ex : Alprazolam (CY3A4/5) + Millepertuis (inducteur puissant du CY3A4/5) **D'après LPEV** → Diminution de l'efficacité de l'Alprazolam.

	CYP1A2	CYP2C9*	CYP2D6*	CYP3A4
SUBSTRAT	théophylline caféine	Phénytoïne Diclofenac Warfarine	codéine captopril imipramine fluoxétine metoprolol	ciclosporine tacrolimus ketoconazole midazolam statine
INHIBITEUR	cimétidine quinolones fluvoxamine  SFN  CHARDON MARIE	Isoniazide ritonavir  CURCUMA	quinidine fluoxetine  CHARDON MARIE  CURCUMA	macrolides naringenine (jus pamplemousse) Antifongiques azolés Antiprotéases  CHARDON MARIE  CURCUMA  SFN
INDUCTEUR	rifampicine omeprazole cigarette  RÉGLISSE	rifampicine	  FUMETERRE	carbamazépine phénytoïne phénobarbital Millepertuis (tisanes...)  MILLEPERTUIS

Cholestase, cytolyse

Cholestase : Réduction ou arrêt du flux biliaire

Cytolyse hépatique : Destruction des cellules

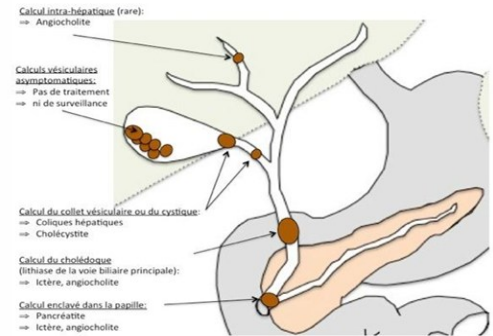
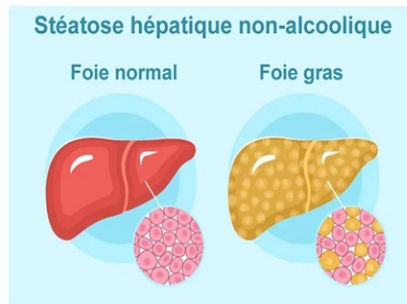
Paramètres	Cholestase	Cytolyse
Albumine	N	N
Bilirubine	N ou augmenté	N ou augmenté
Cholestérol	Augmenté	N
Fer	N .	Augmenté
Gamma GT	Augmenté	N ou augmenté
LDH	N	Augmenté
Phosphatases alcalines	N ou augmenté	N ou augmenté
Transaminases	N ou augmenté	Augmenté +++
TP	Bas avec un facteur V normal	N
Vit A, D, E, K	Bas	N

« N » = neutre

NASH ou NAFLD

Définitions

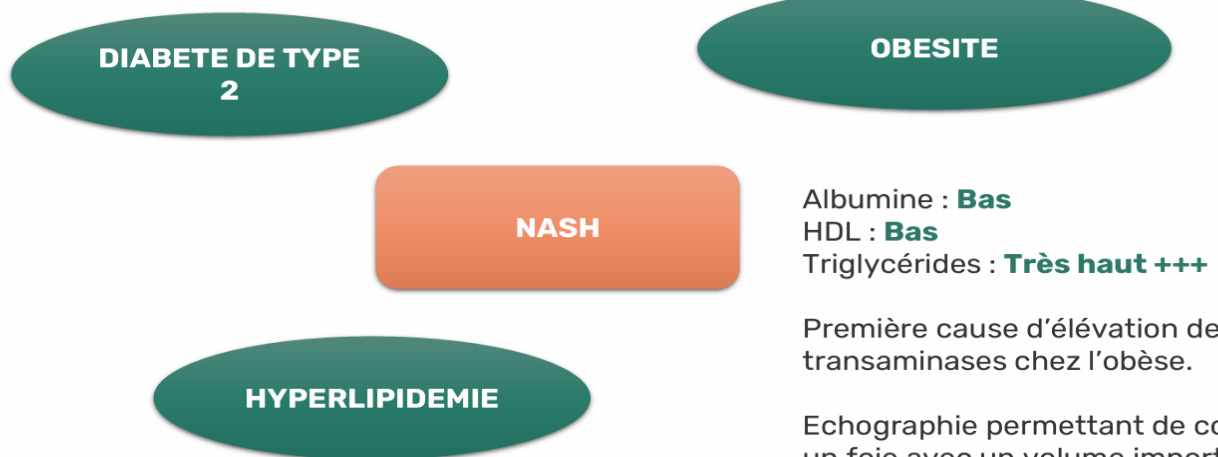
	NASH ou NAFLD (Stéatose hépatique)	LITHIASES BILIAIRES
Définition / Symptômes	NASH = Stéato Hépatite Non Alcoolique NAFLD = Non Alcoholic Fatty Liver Disease Accumulation de graisse dans les cellules du foie.	Calculs qui se forment dans la vésicule biliaire et qui peuvent migrer dans les voies excrétrices biliaires. Asymptomatique le plus souvent. Parfois, douleurs sous les côtes en haut et à droite de l'abdomen. Se diagnostique par échographie.



NASH

- ⇒ peut être détecté par une échographie
- ⇒ donne souvent l'indication d'un syndrome métabolique

Facteurs favorisants



Ce que l'on propose :

En allopathie



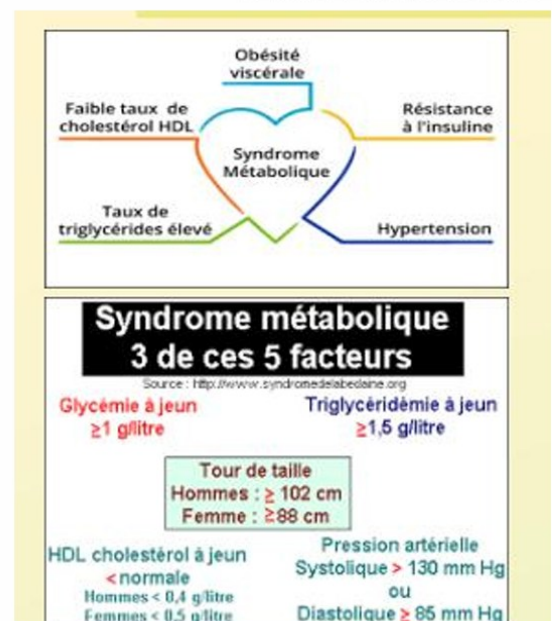
En naturopathie



OBJECTIF

Agir sur les causes du syndrome métabolique

Traitement et accompagnement adapté à chaque situation (cf. cours pathos cardio-vasculaires + Conseils hygiéno-diététiques)



Phytothérapie appliquée

Cholérétique :

Stimule la production de bile par le foie

Cholagogue :

Facilite l'évacuation de la bile

	CHOLÉRÉTIQUE	CHOLAGOGUE	PHASE I	PHASE II	HÉPATO PROTECTEUR	NASH
ARTICHAUT	amphocholérétique	++	+	++	++	
CHARDON MARIE	++	++	--	++	++	+++
CHLORELLA			--	++		
CURCUMA	++	+	--	+++	+++	+++
DESMODIUM			?	+	+++	++
FUMETERRE	amphocholérétique	++	++	?		
LIN			?	+++		
MILLEPERTUIS	+		+++	?	+	
RADIS NOIR	++	++	--	+++		
RÉGLISSE			+	++	+++	+++

	CHOLÉRÉTIQUE	CHOLAGOGUE	PHASE I	PHASE II	HEPATO PROTECTEUR	NASH
ROMARIN	+	+	+	++	++	++
ROMARIN JEUNE POUSSE	+++	+++	+	++	+++	+++
GENEVRIER JEUNE POUSSE	++	++	--	+++	++	++
CHRYSANTELLUM AMERICANUM				+	++	++
SCHISANDRA			++	+		++++

D'après LPEV

Si l'on souhaite utiliser des plantes hépatiques

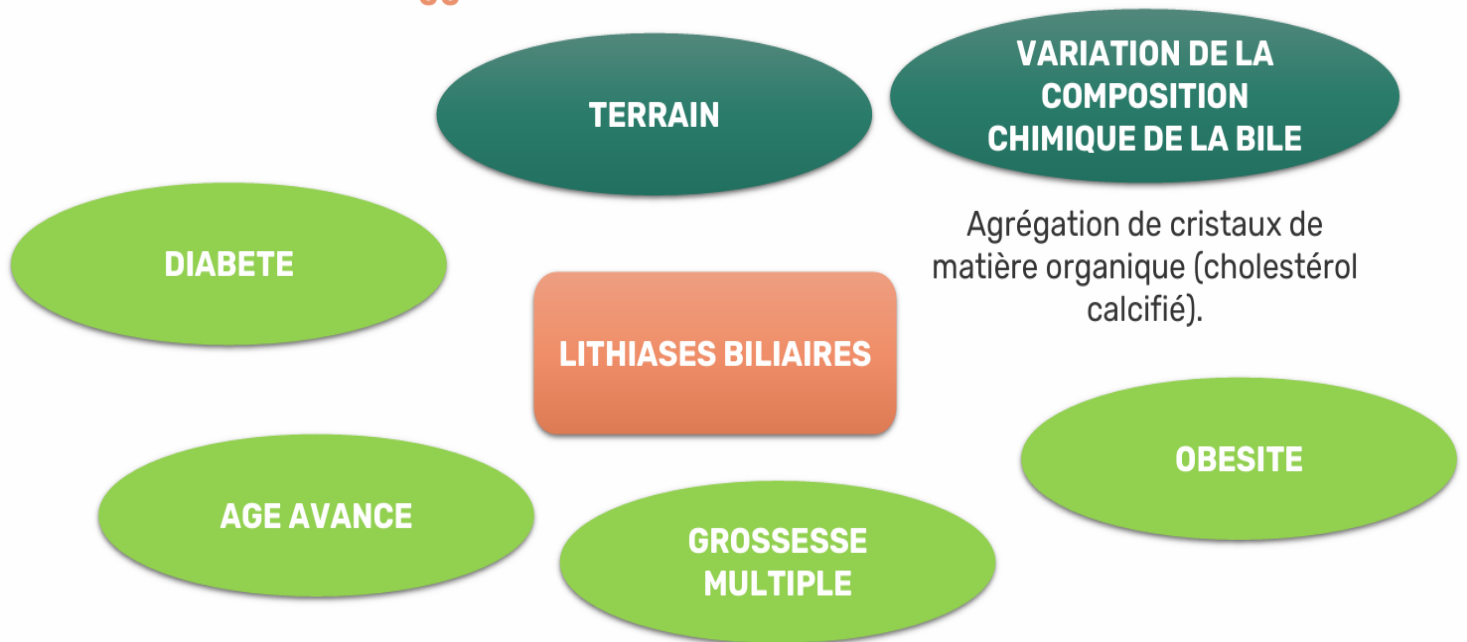
1. Vérifier les interactions avec les traitements médicamenteux de la personne via le tableau (s'il y en a)
2. Vérifier si la personne n'a pas de calcul biliaire et des antécédents familiaux . Et si le cas ne pas conseiller la prise de plantes hépatiques car cela peut être dramatique et finir en pancréatite
3. Il est très important de donner des plantes qui vont agir a la fois en phase 1 (detox) et phase 2
⇒ **Pourquoi ?** (Voir schémas avec les phases)

Car si on donne des plantes qui vont stimuler uniquement la phase 1, vous allez vous retrouver avec des métabolites intermédiaires qui sont toxiques pour le foie .

⇒ **Donc il faut absolument mettre des plantes de la phase 1 et phase 2**

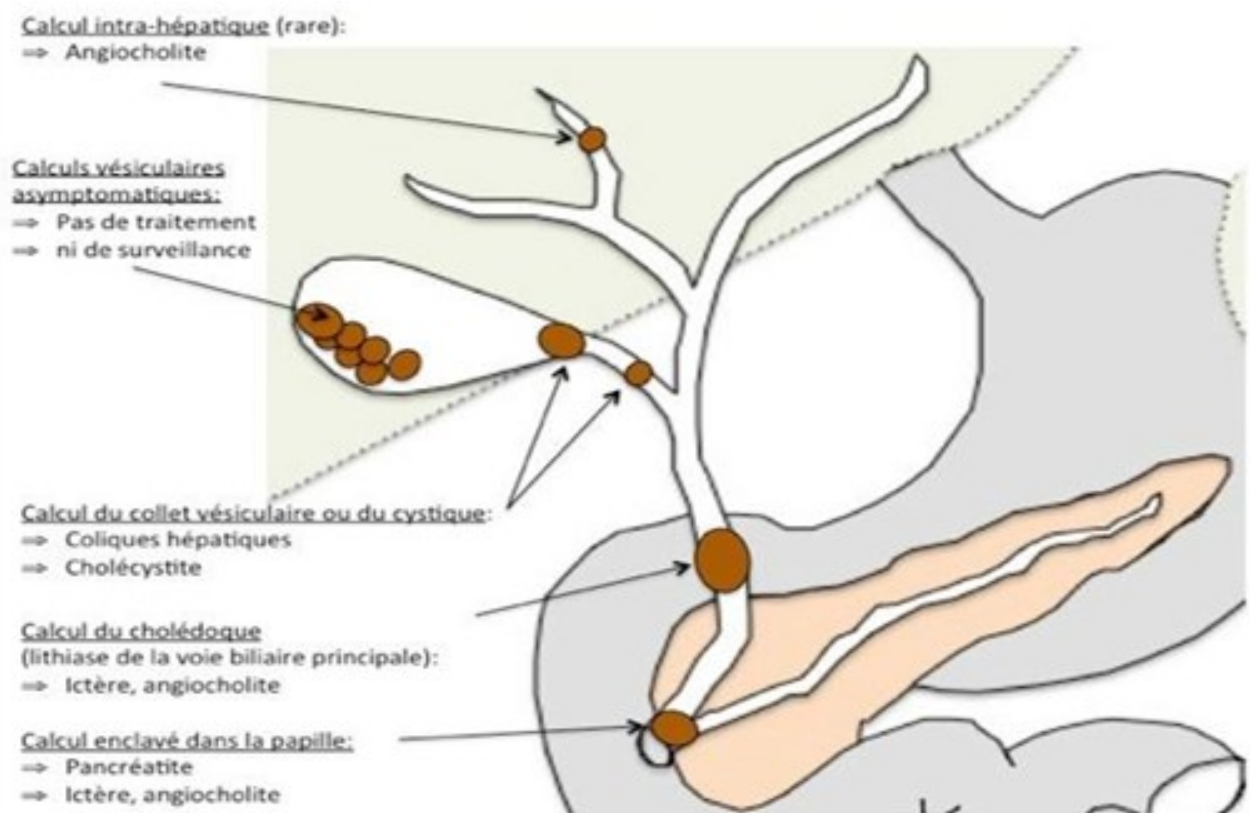
Lithiases biliaires

• Causes et facteurs aggravants



Vet fonce = les causes

Vert clair = facteurs aggravants

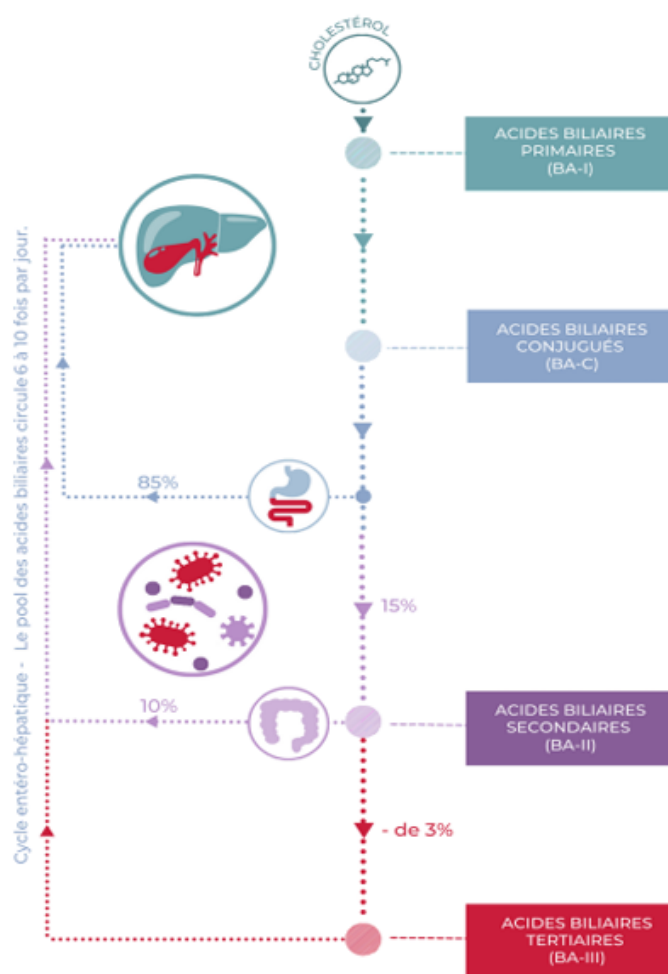


Menez l'enquête - Les questions à poser en consultation

- « Y-a-t-il des calculs biliaires dans votre famille? »
- « Avez-vous encore votre vésicule biliaire? »
- « Quel est votre taux de cholestérol? »
- « Vos selles sont-elles grasses ? »

Menez l'enquête - Les bilans spécialisés recommandés

- Les acides biliaires pour évaluer la qualité de la bile



D'après LIMS

ACIDES BILIAIRES PRIMAIRES

CA	Acide cholique	0.01	μmol/L	0.01 - 0.4
CDCA	Acide chénodésoxycholique	0.008	μmol/L	0.017 - 0.45

ACIDES BILIAIRES SECONDAIRES

DCA	Acide désoxycholique	0.15	μmol/L	0.06 - 0.45
LCA	Acide lithocholique	0.009	μmol/L	0.002 - 0.022

ACIDES BILIAIRES CONJUGUÉS

GCA	Acide glycocholique	0.017	μmol/L	0.02 - 0.25
AGDC	Acide glycochénodésoxycholique	0.066	μmol/L	0.15 - 1.35
TCA	Acide taurocholique	0.017	μmol/L	0.03 - 0.775

ACIDES BILIAIRES TERTIAIRES

UDCA	Acide ursodésoxycholique	0.013	μmol/L	0.004 - 0.085
------	--------------------------	-------	--------	---------------

Carence en fer ?

Carence en vitamine B3 ?

Manque de cholestérol ?

Dysbiose ?

Malabsorption des vitamines ADEK ?

Manque de L-glycine ou taurine ?

Ce que l'on propose :



En allopathie

OBJECTIF

Eviter la migration des calculs dans les voies biliaires et par conséquent une pancréatite

- En fonction de la localisation des calculs, pas de traitement ou ablation de la VB.

En naturopathie

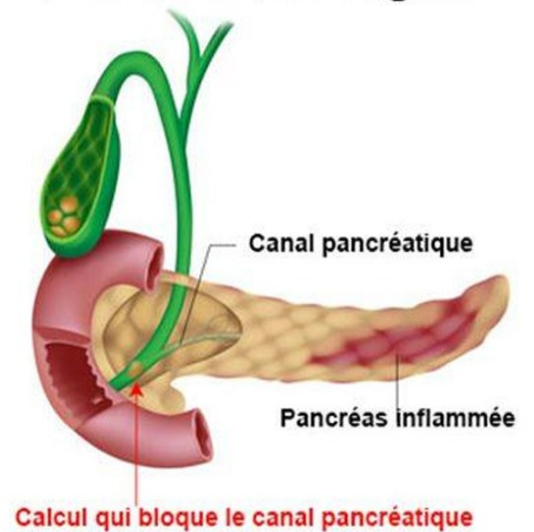


- **Surtout ne pas préconiser de plantes hépatiques au risque de provoquer la migration des calculs dans les voies biliaires.**
- Si **ablation de la VB**, la bile n'est plus stockée et se déverse continuellement. Dans ce cas, il faut **soutenir la digestion des graisses et optimiser la qualité de la bile.**

Pancréatite

	PANCREATITE
Définition / Symptômes	Inflammation aiguë du pancréas (œdème et/ou nécrose) Douleur violente dans la moitié supérieure de l'abdomen
Causes	Alcoolisme Migration de calculs dans les voies biliaires
Diagnostic	Mesure des enzymes pancréatiques dans le sang (taux anormalement élevé dans le sang) + échographie et scanner

Pancréatite aiguë



Ce que l'on propose :



En allopathie

OBJECTIF

Soulager la douleur en mettant le système digestif au repos et en luttant contre l'inflammation

- Arrêt de l'alimentation, administration d'inhibiteurs enzymatique, réhydratation, antibiotique, ablation de la VB si calculs.

En naturopathie



- Aucun accompagnement. **Réservé à l'allopathie.**



Bibliographie / webographie

Le Larousse Médical

Ma bible des huiles essentielles, Danièle Festy

Sans candida Albicans, Accompagner une candidose, Valérie Legros, Ed. AMYRIS

Cours «Pathologies du système digestif» Isupnat

Cours de «Phytothérapie appliquée», Isupnat

Cours «d'analyses biologiques», Isupnat

Webinaire LPEV « Maîtriser la détoxification, outil majeur d'une prise en charge holistique avec la phytothérapie et la micronutrition»

https://www.hug.ch/sites/hde/files/structures/pharmacologie_et_toxicologie_cliniques/documents/2002_29_4.pdf

